

‘Digitalisering en Databeschikbaarheid als drijvende kracht voor Netwerkzorg in Midden-Nederland’

IZA transformatieplan – versie 0.8 (concept)



Inhoudsopgave

1. Management samenvatting en leeswijzer
 2. Achtergrond en aanleiding
 3. Visie en ambitie
 4. Veranderopgave en verwachte impact
 5. Fundament digitalisering
 6. Thema 1: Digitale (zorg)communicatie
 7. Thema 2: Dossierinzage en digitale overdracht
 8. Overkoepelende businesscase en investeringsaanvraag
 9. Governance en programmastructuur implementatie
 10. Integrale implementatieplanning en monitoring KPI's
 11. Randvoorwaarden voor succes
- Bijlagen
 - A. Detail uitwerking van de usecases
 - B. ...

Management samenvatting



Leeswijzer



Achtergrond & aanleiding



Impact van demografische ontwikkelingen op zorg en welzijn in de regio Midden-Nederland

Inwoners van de regio Midden-Nederland zijn over het algemeen relatief gezond, hebben een hoge sociaaleconomische status en gezonde leefstijl¹. Dit uit zich in een hoge levensverwachting en relatief weinig mensen met chronische aandoening(en). Tegelijkertijd vraagt de (ervaren) mentale gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen aandacht. De demografische druk is hoog en er is meer (dubbele) vergrijzing dan landelijk gemiddeld. Dit stelt Trijn, de regio en haar inwoners voor aanzienlijke uitdagingen.

Stevige dubbele vergrijzing: tussen 2023 en 2040 groeit de regio met 168 duizend inwoners (+12,5%). Het aantal 65-plussers neemt toe met 353 duizend (+23,5%). Vooral in relatie tot ouderen leidt dit tot een verwachte:

- Toename van chronisch zieken, kwetsbare groepen en complexere casuïstiek
- Stijging van vraag naar ondersteuning en zorg

Bovenstaande ontwikkelingen vinden plaats in het licht van uitdagende omstandigheden:



Hoge druk op (in)formele ondersteuning en zorgpersoneel, zowel in de thuissituatie als binnen zorgorganisaties, terwijl mantelzorgpotentieel afneemt.



Grote gezondheidsverschillen in de regio, voortvloeiend uit populatieverschillen tussen gemeenten en wijken en sociaal economische kenmerken. Dit beïnvloedt de vraag naar formele en informele zorg.



Moeizame organisatie en samenwerking: financiering, wet- en regelgeving en praktische bezwaren staan samenwerking in de weg. Inwoners en zorgprofessionals ervaren de zorg als versnipperd, waarbij vraag en aanbod van zorg zowel lastig samenkomen als inzichtelijk zijn.

PLACEHOLDER
Plaat ontwikkeling zorgkosten

of

Plaat ontwikkeling zorgvraag



De uitdagingen vragen om beschikbaarheid van data in de regio

Regionale samenwerking wordt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) genoemd als belangrijke voorwaarde voor de “juiste zorg, op de juiste plek”. De regiopartijen hebben Trijn gepositioneerd om de fundamenteopgave digitalisering en gegevensuitwisseling, als onderdeel van het IZA Regioplan MNL uit te voeren. Via digitalisering en (netwerk) zorgtoepassingen, moet de toegankelijkheid van zorg gewaarborgd blijven, het zorggebruik verminderen of verplaatsen, en de druk op professionals afnemen.

Databeschikbaarheid is voorwaardelijk aan het realiseren van domein overstijgende samenwerking in het netwerk van zorg en welzijn en het optimaal benutten van beschikbaar personeel en expertise. In de huidige situatie zien wij echter door gebrekkige gegevensuitwisseling en beschikbaarheid van data, een groot aantal uitdagingen en terugkerende problematiek in de praktijk ontstaan.

Voor de professional

- Dubbele diagnostiek, onder- of overbehandeling
- Medische fouten
- Inefficiënte tijdsbesteding, extra administratieve druk
- Gebrekkige multidisciplinaire samenwerking
- Lage patiëntveiligheid
- Verspilling van zorggeld
- Beperkte mogelijkheid efficiënt inzetten van eHealth, zorgtechnologie en AI
- Vermindering van werkplezier
- Uitstroom van professionals, minder instroom nieuwe professionals

Voor de inwoner

- Meermalen hetzelfde verhaal vertellen
- Zeggenschap niet goed geregeld
- Onvoldoende toegang tot eigen gegevens
- Slechte mogelijkheid om eigen gegevens te delen met professionals
- Onvoldoende mogelijkheid om zelf te schakelen met het professionele netwerk, of tussen professionele en informele netwerk
- Onvoldoende inzicht in het aanbod
- Onvoldoende toegankelijkheid tot keuzehulpen, apps en formulieren
- Onvoldoende ervaren eigen regie



De digitaliseringsopgave in de regio is omvangrijk en grijpt terug op landelijke thema's

In de komende jaren werken we als regio enerzijds aan een gezonde en passende leefomgeving en anderzijds aan vernieuwing binnen het medische en sociaal domein, gericht op integrale (gezondheids)zorg. Het welbevinden van mensen staat hierin centraal. Ons uitgangspunt is het belang van de algehele gezondheid en ieders vermogen om met levensuitdagingen om te gaan.

Het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling sluit aan bij de inhoudelijke opgaven beschreven in het IZA regioplan Midden-Nederland. Vanuit het eerste thema in de (inter)regionale fundamentopgave, elektronische gegevensuitwisseling, toegankelijkheid en registratie, wordt toegewerkt naar meer standaardisatie van gegevensuitwisseling, een verbeterde toegankelijkheid van informatie en éénmalige, gestandaardiseerde verslaglegging. Deze opgaven zijn voorwaardelijk voor de regionale, domein overstijgende samenwerking en het optimaal benutten van beschikbaar personeel en expertise. Er wordt gebouwd op een drietal (3) pijlers¹:



**Elektronische
gegevensuitwisseling,
toegankelijkheid en
registratie**

- **Standaardisatie van gegevensuitwisseling** via een landelijk dekkend netwerk van ICT-infrastructuren en -systemen dat moet leiden tot eenheid in taal en techniek
- **Toegankelijkheid en begrijpelijkheid** van informatie vergroten voor de patiënt, cliënt of burger, naast goede uitwisseling tussen (in)formele hulp- en zorgverleners
- **Eénmalige en gestandaardiseerde vastlegging** van data voor gebruik van diverse secundaire doeleinden

1) Netwerkzorg

- Vanuit het perspectief van inwoners
- Vanuit het perspectief van professionals

2) Basis op orde

3) Regionale data- en applicatieitectitectuur

Digitalisering is voorwaardelijk voor het transformeren van de zorg.

1. Klik [hier](#) voor de interactieve samenvatting van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling uit het IZA regioplan Midden-Nederland



Visie & ambitie voor de transformatie opgaven in de regio Midden-Nederland



Vergezicht

Het is maart 2027 ...

Rifa, een vrouw van 27 jaar, ervaart veel stress door financiële problemen, druk vanuit social media en zit in sociale isolatie door schaamte. Door gebrek aan geld heeft ze een ongezond eetpatroon en overgewicht. Soms heeft ze last van spontane benauwdheid en lijkt het alsof ze hartkloppingen heeft. Na lang wikken en wegen heeft ze besloten om over een drempel van schaamte heen te stappen en hulp te zoeken in de buurt. Via het buurtcentrum komt ze in contact met een buurtteam.

Tijdens de kennismaking met Rifa heeft de buurtverbinder (na toestemming van Rifa) inzage in haar digitale dossier. De buurtverbinder voegt het verslag van hun kennismaking toe aan het dossier en meldt haar aan voor het eerstvolgende multidisciplinaire overleg binnen het buurtteam. Het buurtteam schakelt met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). De POH voert een ECG uit en brengt Rifa's huisarts op de hoogte. De huisarts verwijst Rifa door naar de cardioloog. De cardioloog besluit na triage van de verwijzing deze casus via een meedenkconsult (via zorgviewer) met de huisarts te bespreken. De cardioloog bevestigt via het meedenkconsult dat er geen medische oorzaak is voor de hartkloppingen en adviseert dat behandeling via 1^e lijns zorg voldoende is. De huisarts bespreekt deze uitkomst met Rifa en het multidisciplinaire verslag van het gesprek komt in Rifa's dossier.

Daarna bespreekt de POH met het buurtteam andere factoren van Rifa's situatie. Haar overgewicht draagt mogelijk bij aan haar klachten en zij stellen, na kort overleg met haar huisarts, een traject voor binnen het Gecombineerd Leefstijl Interventie (GLI)-programma, samen met een leefstijlcoach. Rifa geeft aan dat haar stress vooral voortkomt uit financiële problemen. Met Rifa's toestemming schakelt het buurtteam de schuldhelpverlening in en bekijkt mogelijkheden om Rifa's sociale netwerk te versterken, bijvoorbeeld via vrijwilligersorganisaties of lotgenotengroepen.

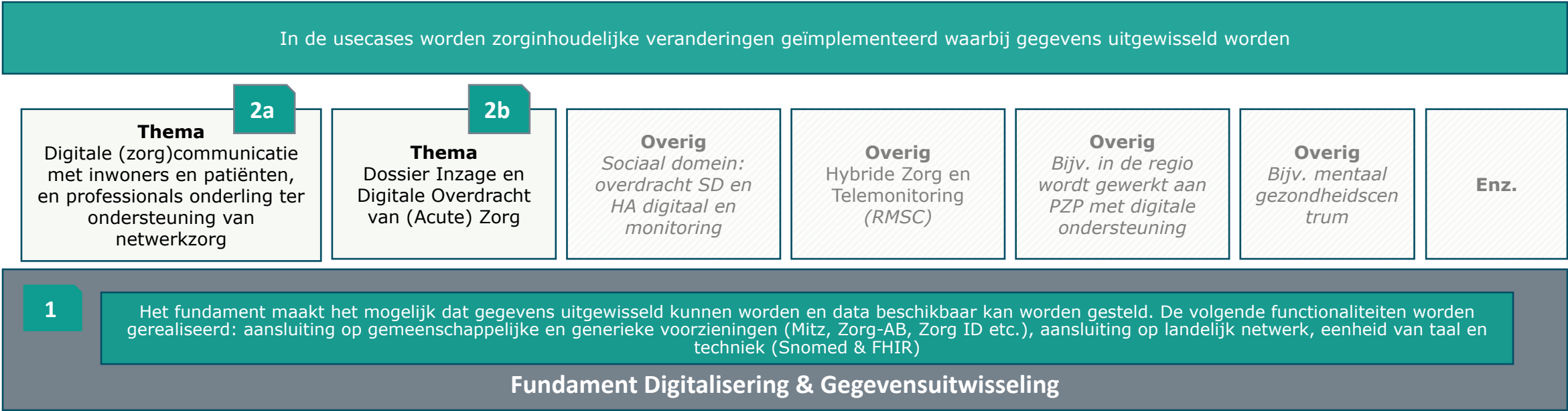
De samenwerking tussen de huisarts, het buurtteam en andere relevante (zorg)professionals vindt plaats via één digitale overlegomgeving. Hier loggen professionals via hun eigen systeem in op een netwerkzorg viewer. Via deze omgeving hebben zij, met toestemming van Rifa, direct inzage in de (medische) gegevens van Rifa en kunnen zij gemakkelijk met elkaar communiceren. Rifa en haar naasten kunnen zelf het dossier van Rifa ook inzien via één digitale voordeur, namelijk via een app. Vanuit hier kan Rifa ook contact leggen met de zorgprofessionals via telefoon, chat of mail. Ze kan zelf haar gegevens aanpassen indien nodig en krijgt via het portaal meldingen. Rifa kan zelf bepalen wie ze toegang verleent tot deze omgeving, om zo bijvoorbeeld een mantelzorger mee te laten kijken in haar dossier.

De (medische) gegevens van Rifa worden middels koppelvlakken met bronsystemen real-time opgehaald uit de verschillende bronsystemen binnen het netwerk en samen op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Voorbeelden van deze gegevens zijn basisgegevens, zoals contacten, adressen, diagnoses, problemen en allergieën. Ook overzichten van medicatie, onderzoeksresultaten en/of overdrachten zoals huisartsenbrieven, verpleegkundige overdrachten of andere documenten. Gelijk wordt duidelijk bij wie of welke (zorg)professional Rifa bekend is, of eerder contact mee is geweest. Hierdoor kunnen zorg- en hulpverleners Rifa op een holistische manier triëren.

Scope aanvraag fundament digitalisering en gegevensuitwisseling Midden-Nederland

Deze aanvraag richt zich 1) op het leggen van het fundament voor digitalisering & gegevenstuitwisseling in de regio MNL. Dit fundament wordt domein overstijgend gelegd voor de ZvW, WLZ en sociaal domein. Op dit fundament kunnen in de regio usecases worden aangesloten. 2) op de implementatie van 2 thema’s gericht op digitale (zorg)communicatie én dossier inzage en digitale overdracht (thema 2a en 2b).

Overige thema’s en usecases worden op een andere manier opgepakt, bijv. in een separaat transformatieplan zoals het NAZMN transformatieplan voor de acute zorg en/of MGMN voor de mentale gezondheid in de regio. Deze usecases maken in principe wel gebruik van het fundament wat wordt gelegd binnen deze transformatieaanvraag, maar de uitvoering en impact worden niet in dit plan meegenomen.



Het Nictiz model laat zien wat in scope van dit transformatieplan valt, voor welke usecases

Use cases wel in dit transformatieplan

Organisatorische eenheid	Afspraken over:	
ORGANISATIEBELEID	Totaal: Visie en plan vorming, governance vraagstukken, aansluiting regioplan, impact op IZA doelstellingen, business case	✓
ZORGPROCES	Usecases: Regionale werkafspraken transmurale zorgprocessen (RTA's), digitale-) Zorgpaden, procesveranderingen, KPIs	✓
INFORMATIE	Fundament: Eenheid van taal & landelijke standaarden, KPIs	✓
APPLICATIE	Usecases: Keuze van applicaties, koppelingen van applicaties met aanbieder systemen	✓
IT-INFRASTRUCTUUR	Fundament: Gemeenschappelijke voorzieningen & generieke functies (Mitz, Zorg-AB Zorg ID), KPIs	✓

Use cases niet in dit transformatieplan

Organisatorische eenheid	Afspraken over:	
ORGANISATIEBELEID	Totaal: Visie en plan vorming, governance vraagstukken, aansluiting regioplan, impact op IZA doelstellingen, business case	✗
ZORGPROCES	Usecases: Regionale werkafspraken transmurale zorgprocessen (RTA's), digitale-) Zorgpaden, procesveranderingen, KPIs	✗
INFORMATIE	Fundament: Eenheid van taal & landelijke standaarden, KPIs	✓
APPLICATIE	Usecases: Keuze van applicaties, koppelingen van applicaties met aanbieder systemen	✗
IT-INFRASTRUCTUUR	Fundament: Gemeenschappelijke voorzieningen & generieke functies (Mitz, Zorg-AB Zorg ID), KPIs	✓

Voor usecases die wel in dit transformatieplan worden meegenomen worden alle lagen van het Nictiz model meegenomen. Het gaat hier zowel om de technische kant als de zorginhoudelijke en implementatie kant van een usecase. Met deze usecases maken we binnen dit transformatieplan impact op zorggebruik in de Zvw en/of inzet van personeel.

Usecases die niet in dit transformatieplan worden meegenomen maken wel gebruik van de informatie en IT-infrastructuur laag die in dit transformatieplan wordt gelegd. Partijen committeren zich hiermee om bij nieuwe usecases altijd gebruik te maken van de gekozen gemeenschappelijke voorzieningen, de gekozen eenheid van taal en aansluiting bij het landelijk netwerk. Op deze manier zorgen we ervoor dat stapsgewijs gebouwd kan worden aan regionale en landelijke gegevensuitwisseling.

De overige lagen van het model, die de zorginhoudelijke invulling en applicatielaag beschrijven, worden apart opgepakt. Dit bevat bijvoorbeeld de beschrijving van het nieuwe zorgpad, eventuele aanvullende apps/devices/afspraken die nodig zijn naast het fundament en de benodigde koppelingen tussen bv HIS/ZIC/CIS en de applicatie om data te kunnen uitwisselen en registreren. Verder wordt daar ook de implementatie opgepakt en de impact op zorggebruik.

Concretisering samenhang met andere transformatieplannen in de regio

Op verschillende onderdelen van de domein overstijgende transformatieopgaven, wordt samengewerkt in de regio. De belangrijkste in relatie tot het fundament digitalisering en de samenhang worden hier weergegeven.



Concretisering samenhang met andere programma's en projecten in de regio

Op verschillende onderdelen van de domein overstijgende transformatieopgaven, wordt samengewerkt in de regio. De belangrijkste in relatie tot het fundament digitalisering en de samenhang worden hier weergegeven.



Netwerkzorg vraagt om domeinoverstijgende samenwerking en data beschikbaarheid

In de komende jaren werken we als regio enerzijds aan een *gezonde en passende leefomgeving* en anderzijds aan vernieuwing binnen het medische en sociaal domein, gericht op *integrale (gezondheids)zorg*. Om domeinoverstijgend te werken en te komen tot integrale gezondheidszorg is er een tweede casus beschikbaar voor de regio Midden-Nederland namelijk casus Theo.

Met Theo als persona in een casus wordt op een eenduidige manier de toekomstige patiëntreis van een typische inwoner geschetst. Hierbij raakt de patiëntreis van Theo zowel de 1^e als 2^e lijnszorg. Daarnaast ook de thuissituatie als binnen de muren van een zorginstelling. Ook omvat deze casus enkele veelvoorkomende overdrachten waarbij er gewisseld wordt van (type) zorgverlener.

Persona Theo

Theo is 82 en houdt van vissen. Theo was getrouwd met Greet, maar Greet is een jaar geleden overleden. Theo is in slechte conditie, licht dementerend en heeft thuiszorg. Hij is dol op het contact met zijn kinderen en kleinkinderen.



Reis van Theo

Theo wordt overvallen door een hersenbloeding. Na de eerste opvang in het ziekenhuis, wordt hij tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum. Tijdens zijn revalidatietraject wordt er medicatie voorgeschreven en er wordt overleg gepleegd met de behandelend arts uit het ziekenhuis. Later komt Theo toch tijdelijk in een verpleeghuis terecht.

Na zijn revalidatie en verblijf in een verpleeghuis, gaat Theo weer thuis wonen. Hij wordt hierbij ondersteund door een wijkverpleegkundige. Zijn huisarts of het verpleeghuis schakelt de wijkverpleegkundige in. De wijkverpleegkundige, huisarts, zijn familie en hijzelf merken na verloop van tijd op dat thuis wonen niet meer gaat. Theo verhuist naar een verpleeg- en verzorgingshuis waar hij de rest van zijn leven zal wonen.

Tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis vertoont Theo agressief gedrag. De hulp van een gespecialiseerde ggz-instelling wordt ingeschakeld. Daarbij krijgt Theo last van een hoge bloeddruk, waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medicatie voorschrijft. Theo's zicht vermindert. Hij ondergaat hiervoor een staarbehandeling in het ziekenhuis, waarna hij weer terugkeert naar het verpleeghuis.

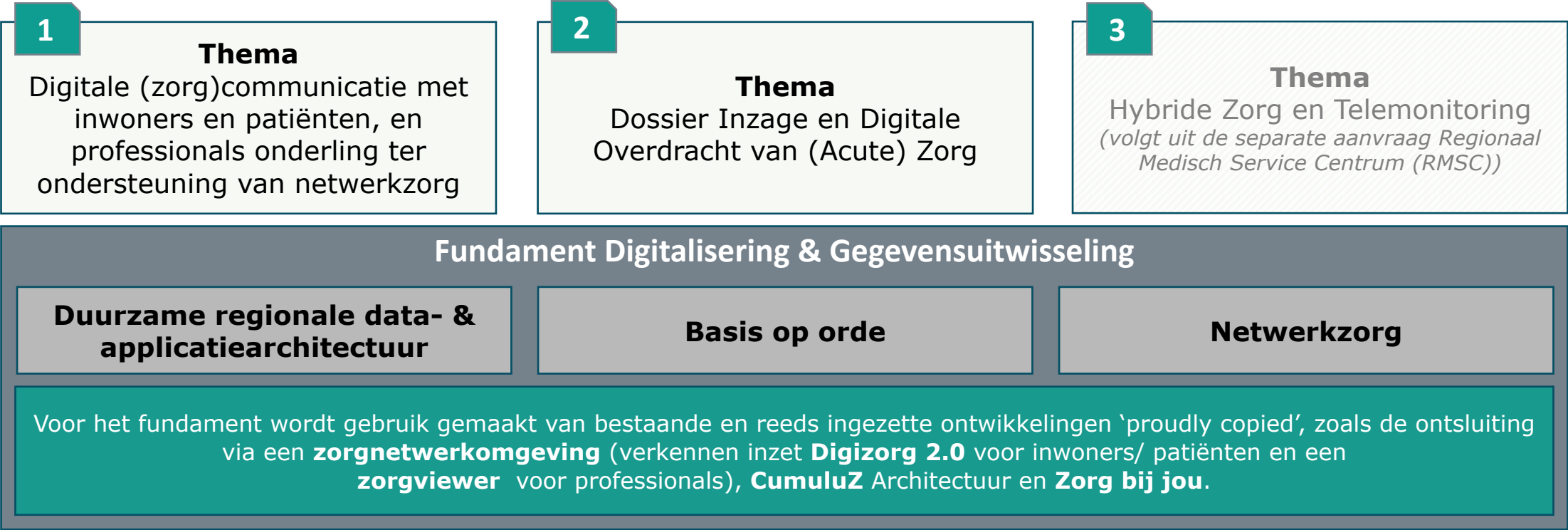


Veranderopgave & verwachte impact

Overzicht aanvraag fundament digitalisering en gegevensuitwisseling Midden-Nederland

Vanuit de regio zijn binnen de drie (3) pijlers Netwerkzorg, Basis op orde en de Regionale data- en applicatiearchitectuur, drie (3) thema’s voor de digitale transformatie in de regio geïdentificeerd. In dit transformatieplan worden de eerste stappen (prioritering) beschreven aan de hand van de thema’s, die direct impact maken op zorg en ondersteuning in de regio.

Deze aanvraag betreft thema’s 1, 2 én onderdelen van de grijze laag, namelijk het fundament Digitalisering & Gegevensuitwisseling, die onlosmakelijk verbonden zijn met de realisatie van deze thema’s.





Scope Transformatieplan – Regionaal en wettelijk bepaalde prioritering van thema's en use cases

De regionale transformatieopgave bestaat uit acht (8) usecases die binnen de twee thema's vallen. Het thema "Digitale (zorg)communicatie" omvat het procesontwerp, selectie en implementatie van digitale zorgtoepassingen (applicaties). De usecases zijn geprioriteerd vanuit regio beleid, in samenspraak met de leden en partners van Trijn. Het thema "Dossier inzage en digitale overdracht" bestaat uit het realiseren van gegevensuitwisselingen en databeschikbaarheid middels een netwerkgorg viewer. De usecases hierbij zijn primair ingegeven vanuit wetgeving (Wet EGIZ).

1

Thema 1.0

Digitale (zorg)communicatie met inwoners en patiënten, en professionals onderling ter ondersteuning van netwerkgorg

1.1 Meedenkconsult

Faciliteren collegiaal overleg ter vermindering onnodig doorsturen.

1.2 Digitaal verwijzen

Digitale transmurale verwijzing en dossier informatie bij overdracht.

1.3 Tweewegcommunicatie

Zorgnetwerkomgeving gebruikt door inwoner en zorgprofessionals.

2

Thema 2.0

Dossier Inzage en Digitale Overdracht van (Acute) Zorg

2.1 Basisgegevensset Zorg Medisch Specialistische Zorg

Realiseren van de BgZ gegevensuitwisseling voor MSZ.

2.2 Medicatieoverdracht

Realiseren van medicatie- en labgegevensuitwisseling.

2.3 Verpleegkundige Overdracht (eOverdracht)

Realiseren van de eOverdracht gegevensuitwisseling.

2.4 Acute zorg

Gefaseerde realisatie van gegevensuitwisselingen uit de richtlijn Acute Zorg.

2.5 Netwerkgorg viewer voor Multidisciplinaire inzage ¹

Uitwerken randvoorwaarden, selectie en implementatie gedeelde viewer.

0.0 Fundament Digitalisering & Gegevensuitwisseling

Concretiseren ontwerp regionale Data & Applicatie Architectuur en roadmap/ planning om deze technische zaken in te richten ¹

¹ Is onderdeel van het transformatieplan en ontwikkeling vindt parallel plaats met de realisatie van de usecases

Zorgtransformatie en impact op inwoners en professionals in de regio Midden-Nederland

[Placeholder]

...

Verwachte domeinoverstijgende impact op zorg- en welzijns aanbieders

[Placeholder]

...

Veranderstrategie om de verwachte resultaten van de zorgtransformatie te realiseren

[Placeholder]

...

Stakeholderbetrokkenheid en communicatieplan tijdens de implementatie en (zorg-)transformatie

Voor het samen optrekken in de regio, verbinden we met stakeholders die vanuit de inhoud, management rol, danwel effecten betrokken zijn bij de processen en/of impact van de transformatie

[Placeholder]

...



Stakeholderbetrokkenheid en communicatie

Doelstellingen betrokkenheid stakeholders: Waarom zijn we betrokken?

Afstemming over de doelen en verwachtingen op het niveau van leiderschap, deelnemers, uitvoerders, zorgverleners én inwoners/ patiënten

Startpunt verandering, nodig voor executie en uitrol. Gedragen transformatie plan, vanuit de deelnemers en het IZA; gelijkgerichtheid.

Valideren en committeren aan impact en onderliggende business case voor transformatie opgaven in de regio.

Sleutelgroepen: Wie zijn betrokken?

Kernteam – Vanuit regionale governance structuur

RSO Trijn – Programma management

Werkgroepen – Werkgroepen, t zorgveld,

Stuurgroep digitale transformatie– Bestuurders, wel mandaat om besluiten te nemen

Inwoners – Vertegenwoordiging en consultatie door werkgroepen

1. Leden RSO Trijn – Bestuurders (breder dan stuurgroep)
2. Partners RSO Trijn – Bestuurders (breder dan stuurgroep)

Architectuurraad – Architecten/ICT managers (80% kerngroep), adviserend

Aanpak: Hoe zijn we betrokken?

Betrokkenheid principes

- **Transparantie en vertrouwen** – We zijn open over geleverd werk, verwachtingen en communicatie.
- **Inclusieve en adequate vertegenwoordiging** – De juiste vertegenwoordiging met het juiste mandaat wordt aangehaakt waar nodig.
- **Effectieve ondersteuning** – Met oog op de reeds bestaande tijdsdruk in de zorg, een werkbaar schema met passende ondersteuning

- Commitment
- Analyse & business case
- KPI's / mijlpalen en i
- Ontwikkelen integrale, regionale roadmap
- Inrichten regionale (programma) governance
- Bewaken gelijkgerichtheid

Afstemmingsmomenten en communicatie

Alle sleutelgroepen ontvangen algemene informatie over inhoud, proces en beoogde verandering / impact. Gerichte en aangepaste communicatie per domein MSZ, Huisartsen, VVT, GGZ, Acute zorg, inwoners etc.

Communicatieplan – Uitwerking verhaallijn voor regelmatige (i.e. 2-wekelijkse) schriftelijke en korte contactmomenten bv. op programma en/of thema niveau. Actualiteit op website Trijn.

Kritische Succesfactoren

Actieve, tijdige samenwerking met sleutelgroepen

Gemeenschappelijke visie voor gedeelde resultaten

Krachtige programma governance



Uitwerking van de transformatie-opgaven en usecases

1.1	Thema	2.1	Thema
Digitale en (zorg)communicatie met inwoners en patiënten, en professionals onderling ter ondersteuning van netwerkzorg		Dossier: Inzage en Digitale Overdracht van (Artsen) Zorg	
1.1 Medisch consult		2.1 Rasin geparmanen Zorg Medisch Specialistische Zorg	
1.2 Digital verwijs		2.2 Medische Overdracht	
1.3 Samenwerking		2.3 Verpleegkundige Overdracht (Verpleegkundig)	
1.4 Samenwerking		2.4 Andere zorg	
1.5 Samenwerking		2.5 Samenwerking	
1.6 Samenwerking		2.6 Samenwerking	
1.7 Samenwerking		2.7 Samenwerking	
1.8 Samenwerking		2.8 Samenwerking	
1.9 Samenwerking		2.9 Samenwerking	
1.10 Samenwerking		2.10 Samenwerking	

Verdieping Thema 1: Digitale (zorg)communicatie met inwoners en patiënten, en professionals onderling ter ondersteuning van netwerkzorg



Digitale (zorg)communicatie voor een impactvolle transformatie van keten, naar netwerkzorg

Om goed in te kunnen spelen op de stijgende zorgvraag en stijgende complexiteit van de zorgvraag is het belangrijk dat partijen in het netwerk rondom de inwoner, samen met de inwoner en elkaar goed en effectief samenwerken. Om samen te kunnen werken is afstemming en communicatie meer en beter benodigd. Dit zal in de regio worden ondersteund ten behoeve van betere netwerkzorg. Thema 1 richt zich op digitalisering van communicatie(middelen). De usecases dragen bij aan het faciliteren van digitalisering in het transmurale netwerk van zorg, waardoor onderlinge afstemming en communicatie makkelijker wordt.

Samenwerking in het netwerk van zorg en welzijn in de regio en het beschikbaar stellen van data behorend bij het meedenkconsult en kort overleg, de digitale verwijzing én de tweewegcommunicatie wordt daarmee gefaciliteerd. Het doel is om te komen tot uniforme, regionale digitale en (zorg)communicatie met inwoners en patiënten, en professionals onderling.

Het betreft de ondersteuning van regionale transmurale afspraken (RTAs) en zorgprocessen over de domeinen en muren van (zorg-) organisaties in de regio. Samenwerking met het sociale domein voor het bepalen van de juiste interventie, ondersteuning of verwijzing is daarbij voorwaardelijk, voor het leveren van meer passende zorg en ondersteuning; ongeacht of dit nu wordt geleverd vanuit het buurtteam, thuiszorg, eerste- of tweede lijn.

Afhankelijk van de context en situatie, zal de communicatie plaatsvinden via passende kanalen en daartoe geselecteerde innovatieve zorgtoepassingen. Deze digitale zorgtoepassingen worden middels een (n.t.b.) digitaal platform voor communicatie en verwijzing beschikbaar gesteld. Dit zal onderdeel uitmaken van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling voor regio Midden-Nederland. De geprioriteerde use cases zijn het meedenkconsult, digitaal verwijzen en tweewegcommunicatie¹ en maken deel uit van het realiseren van digitale en (zorg-) communicatie in (multidisciplinair) netwerkzorg.



Introductie Thema 1: Digitale (Zorg)Communicatie tussen netwerkpartners

De reis van Rifa in relatie tot de usecases en het fundament



Persona Rifa

- Leeftijd: 27
- Heeft een ongezond eetpatroon en overgewicht
- Ervaart stress door financiële problemen en zit in sociale isolatie door schaamte

Reis van Rifa

1. Het buurtteam en praktijkondersteuner (POH) van de huisarts, constateren dat Rifa last heeft van hartkloppingen
2. Het multidisciplinaire buurtteam en POH bespreken Rifa in een online integrale triage. besluit haar door te verwijzen naar een cardioloog. De cardioloog stelt bij de triage van de verwijzing vast dat deze niet nodig is en verwijst Rifa terug naar de huisarts
3. De huisarts verwijst Rifa door naar de cardioloog. Na triage van de verwijzing besluit de cardioloog dit te bespreken via een meedenkconsult.
4. Een leefstijlcoach start een GLI-programma met Rifa en de schuldhelpverlening wordt ingeschakeld. De leefstijlcoach neemt contact op met Rifa en helpt haar verder in de aanpassingen van haar eetpatroon, dieet en leefstijl
5. Rifa en (en met haar toestemming ook haar naasten) kunnen voor vragen terecht bij het digitale loket van het buurtteam

Usecases Thema 1

1.3 Tweewegcommunicatie in zorgnetwerk

Het multidisciplinaire buurtteam kan via één digitale voordeur online met elkaar communiceren.

1.2 Digitale verwijzing

De cardioloog ontvangt de verwijzing digitaal. De verwijzing van Rifa kan digitaal worden afgewezen indien deze als niet passend bij de zorgvraag wordt beoordeeld.

1.1 Meedenkconsult

De huisarts kan laagdrempelig een meedenkconsult bij de cardioloog aanvragen om hun verschillende expertises bij elkaar te brengen t.b.v. de diagnostisering van Rifa.

1.3 Tweewegcommunicatie in zorgnetwerk

Rifa kan vanuit één digitale voordeur contact leggen met de zorgprofessionals via telefoon, chat of mail. Rifa kan zelf bepalen wie ze toegang verleent tot deze omgeving, ze kan bijv. een mantelzorger mee laten kijken in haar dossier.

Fundament

Het fundament zorgt ervoor dat de digitale communicatie tussen netwerkpartners via één digitale voordeur verloopt. Voor inwoners werken we toe naar een patiëntenapp als voordeur en voor zorgprofessionals de netwerkgviewer, waarbij de v i e w e r toegankelijk is vanuit het (bron-) systeem waarmee de professional al werkt.



Usecase 1.1 – Meedenkconsult en Kort overleg
Usecase 1.2 – Digitale verwijzing
Usecase 1.3 – Tweewegcommunicatie in zorgnetwerk



Meedenkconsult, kort overleg en digitale verwijzing – Ambitie

Implementeren en adopteren van domeinoverstijgende digitale (zorg)communicatie, ten behoeve van continuïteit, effectiviteit en efficiëntie van zorg



Kernproblematiek

- Er is onnodige instroom van patiënten in de Medisch Specialistische Zorg (tweede lijn) vanuit de eerste lijn.
- Communicatie tussen huisartsen en medisch-specialisten is tijdrovend. Ze hebben de behoefte om asynchroon met elkaar te kunnen communiceren. Momenteel ontbreken o.a. uniforme werkwijzen.
- Ook digitale verwijzingen en de terugkoppeling daarvan zijn moeizaam en tijdrovend.
- Kwaliteit van bestaande digitale communicatie is momenteel niet altijd toereikend: informatie ontbreekt, is niet eenduidig of onvindbaar.

Link IZA-opgaven

- **Kostenbesparing en optimaal inzetten van beschikbare capaciteit:** Huisartsen en medisch specialisten kunnen elkaar eenvoudig bereiken, op een gestandaardiseerde manier, en op een moment dat beiden uitkomt. Dit vermindert de benodigde tijd en energie die in de huidige situatie nodig is
- **Inzetten op elektronische gegevensuitwisseling en verbeterde zorguitkomsten door betere samenwerking**



Huidige situatie

Afstemming tussen huisarts en medisch specialisten verloopt nog niet altijd digitaal en is daarmee tijdrovend. Voorheen ontbraken hiervoor uniforme werkwijzen. Inmiddels zijn er met het meedenkconsult en kort overleg mogelijkheden die handvatten biedt voor uniforme afstemming rondom digitale asynchrone zorgcommunicatie. Dit is echter beperkt tot een aantal vakgroepen en voornamelijk enkel mogelijk tussen huisarts en medisch specialist en in sommige regio's ook tussen huisarts en de kaderhuisarts.

Bij (digitale) verwijzingen is de terugkoppeling en afstemming tussen verwijzer en medisch specialist inefficiënt. Het is een tijdrovend proces met veel handmatige handelingen (onnodige administratieve last). Terugkoppelen van een getrieerde verwijzing gaat nu vaak telefonisch, is erg tijdrovend, moet tussen consulten door en vereist bereikbaarheid. Er is behoefte om via een digitaal platform laagdrempelig contact de verwijzing te kunnen ombuigen in een meedenkconsult. En om de verwijzing digitaal terug te koppelen aan andere verwijzers naast de huisarts. Er is nu geen oplossing die dit werkproces digitaal ondersteunt.



Ambitie, eind 2026:

- Verminderen van te nemen stappen en handelingen door zorgverlener bij omzetten van meedenkconsult in verwijzing. Nu moet huisarts een geheel nieuwe verwijzing aanmaken met bijbehorende administratieve handelingen.
- In de regio werken met een uniforme werkafspraken rondom het meedenkconsult en kort overleg vanuit de dan beschikbare functionaliteiten
- Uitbreiding in het zorgnetwerk en waar mogelijk sociaal domein om vaker passende zorg te realiseren.
- In gebruik nemen van een best passende software oplossing om kort overleg digitaal te faciliteren.
- Inzichtelijk voor verwijzers en specialisten hoe zij elkaar via welk systeem/platform kunnen bereiken en wanneer.
- Borgen of faciliteren van een verslagvorm dat zowel door huisarts als specialist gekopieerd te kopiëren is in verschillende systemen. Zodat geen informatie verloren gaat. Als toekomstige doorontwikkeling beschikbaar stellen via netwerkzorgviewer.
- Verminderen van te nemen stappen en handelingen van huisarts bij afwijzen van verwijzing. Oftewel: het gehele verwijsproces (inclusief terugkoppeling) digitaal doen met geautomatiseerde berichten en meldingen.



Doorontwikkeling, na 2026:

Toewerken naar communiceren rondom de patiënt middels digitale, asynchrone communicatie waarbij de werkprocessen rondom digitale zorgcommunicatie doorontwikkelen tot een digitale (transmurale) overlegplek. Afstemming tussen zorgprofessionals en met inwoners wordt hiermee laagdrempeliger en eenvoudiger. Mogelijke toepassingen:

- Mogelijkheid om vaker heen-en-weer vragen te stellen tussen huisarts, specialist en betrokkenen in het zorgnetwerk.
- Een FAQ-of bibliotheekfunctionaliteit: waarbij de verwijzer veelvoorkomende vragen en gegeven antwoorden kan inzien.
- Het aanmaken van een 'open verwijzing' door een verwijzer, waarmee de inwoner zelf kan kiezen naar welke vervolgzorg te gaan. Alleen voorbehouden aan bepaalde, digitaal vaardige patiëntgroepen



Tweewegcommunicatie in zorgnetwerk – Ambitie

Implementatie en adoptie van een innovatieve (netwerk-) zorgtoepassing (applicatie), waar zowel patiënten als (zorg-) professionals directe toegang hebben tot relevante informatie en afspraken.



Kernproblematiek

De zorgvraag van inwoners wordt steeds complexer, terwijl informatie versnipperd is over diverse systemen en portalen. Dit leidt tot:

- Hoge administratielast, omdat informatie verouderd, inconsistent is of lastig vindbaar
- Niet altijd de passende opvolging op de zorg- of hulpvraag van de inwoner: beslissingen worden gemaakt op basis van incomplete of onjuiste informatie
- Onnodig hoge vraaglast voor de inwoner of mantelzorger: vaak dezelfde vragen beantwoorden aan diverse zorgverleners

Link IZA-opgaven

- **Betere patiëntervaring:** minder herhaling van uitvraag tijdens anamnese, intake, etc.
- **Lagere zorgkosten:** inwoner komt vaker op de best passende plek voor de vraag terecht
- **Behoud zorgprofessionals:** afname administratieve druk, efficiëntie en tijdsparing bij het verkrijgen, registreren en verifiëren van de (zorg-)informatie
- **Inzetten op elektronische gegevensuitwisseling en verbeterde zorguitkomsten door betere samenwerking**



Huidige situatie

De zorgvraag van inwoners wordt steeds complexer, waarbij medische en sociale hulpvragen vaak met elkaar verweven zijn. Dit vraagt om een zorgaanpak die zowel zorgverleners als het sociaal domein samenbrengt en de zorg en ondersteuning rondom de inwoner organiseert. Echter, de huidige situatie wordt belemmerd door een gebrek aan digitale ondersteuning die deze samenwerking faciliteert. Informatie is versnipperd over verschillende systemen, waardoor zorgverleners geen compleet overzicht hebben en inwoners vaak meermaals om dezelfde gegevens moeten worden gevraagd. Dit verhoogt de administratieve last en leidt tot inefficiëntie en frustratie bij zowel zorgverleners als inwoners. Zonder de juiste digitale oplossingen is het moeilijk om zorg en welzijn effectief en passend af te stemmen op de persoonlijke situatie van de inwoner.



Ambitie, eind 2026:

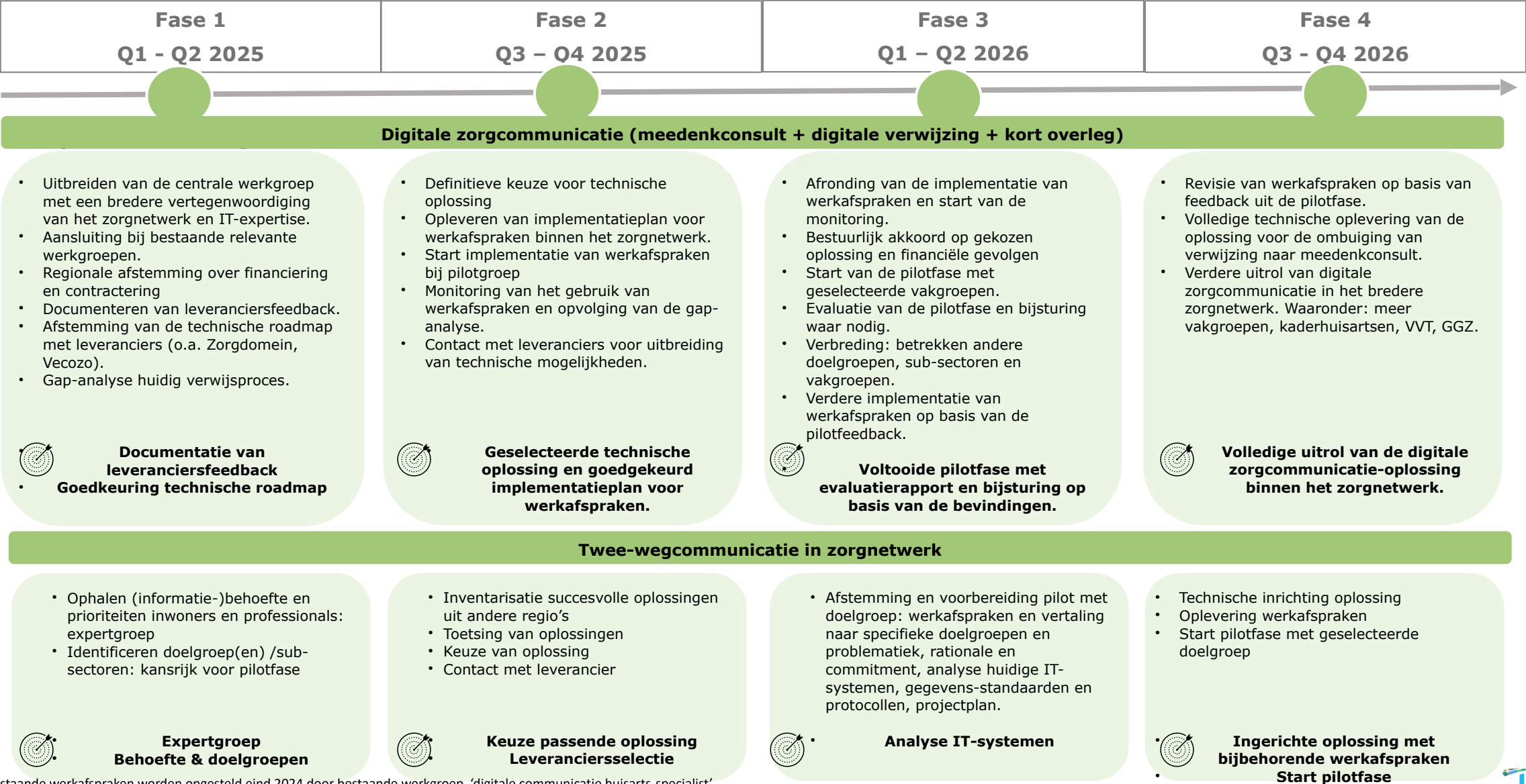
- (Informatie-)behoefte en prioriteiten van inwoners en zorg- en hulpverleners in de regio is duidelijk.
- Identificeren van doelgroep(en) / sub-sectoren die het meest baat hebben bij deze ontwikkeling: ontwikkeling en uitrol zal zich allereerst op hen focussen.
- Inventarisatie en toetsing succesvolle oplossingen uit andere regio's
- Afstemming met voornaamste stakeholdergroepen uit zorgnetwerk over:
 - Werkafspraken en vertaling naar specifieke doelgroepen en problematiek
 - Rationale en commitment
 - Analyse huidige IT-systemen
 - Gegevenstandaarden en protocollen
 - Projectplan



Doorontwikkeling, na 2026:

- (1) Pilotfase met selectie van sub-sectoren: starten met verkennend gesprek voor GGZ en sociaal domein. Daarna opschaling naar sub-sectoren om zorgnetwerk te verbreden.
 - (2) Twee-weg (video)communicatie tussen professionals en met inwoners.
- Deze aanpak bereidt het zorgsysteem voor op de uitdagingen van 2050, zoals vergrijzing en toenemende complexiteit in zorgbehoeften.

Thema 1 Digitale (Zorg)communicatie – Projectfasering



32

1.

Bestaande werkafspraken worden opgesteld eind 2024 door bestaande werkgroep ‘digitale communicatie huisarts-specialist’

2.

Werkafpraak momenteel in de maak bij een bestaande werkgroep

3.

Hierbij aansluiting zoeken bij bestaande werkgroep ‘netwerkgroepplatform’ in regio Midden-Nederland.

Thema 1 Digitale (Zorg)communicatie - Impact

Getallen zijn indicatief en worden nog gevalideerd!!

Regionale tijdswinst en verbeterde ervaring door digitale (zorg)communicatie in de regio



Kwalitatieve impact¹

1

- Verbetering van kwaliteit van zorg door vermeden ziektelast voor inwoners
- Betere zorguitkomsten door betere afstemming in zorg- en hulpverlening tussen professionals

2

- Minder herhaling van vragen van zorgverleners gedurende het zorgtraject
- Meer vertrouwen in zorg omdat eerder verstrekte informatie bekend is bij zorg- en hulpverleners
- Soepelere overgang tussen zorg- en hulpverleners
- Inwoner en het zorgnetwerk hebben een beter inzicht in het zorgtraject

3

- Uniformere, fijnere en efficiëntere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Beter afgestemde zorg en zorg op maat, o.a. door betrekken bredere zorgnetwerk en sociaal domein
- Minder werkgerelateerde stress en meer plezier voor zorgprofessionals door meer tijd voor zorgtaken: minder (telefonisch) contact nodig om inzicht te krijgen in situatie van inwoner
- Zorgprofessionals hebben meer vertrouwen in de informatie die zij hebben/krijgen

4

- Zorgprofessionals zijn minder tijd kwijt aan afstemmen met andere professionals en het zorgnetwerk, omdat zij efficiënter communiceren (minder telefoneren, minder onduidelijkheid, uniformere werkstromen)
- Betere uitkomsten van zorg leiden tot lagere zorgkosten.
- De inwoner blijft langer en beter in beeld bij de eerste lijn of nulde lijn. Draagt hiermee bij aan preventie en voorkomen van (dure) vervolgzorg
- Inwoner en zorgnetwerk hebben meer regie op zorgproces, leidend tot minder onnodige zorghandelingen (ziekenhuisbezoek, huisartsconsulten, etc.)

Kwantitatieve impact ²								
Doelgroep	Aantal geweigerde digitale verwijzingen <i>Ca. 84.000 per jaar</i>		Aantal meedenkconsulten <i>Ca. 28.000 per jaar</i>		Aantal kort overleggen <i>Ca. 5.500 per jaar</i>		Aantal eerste polibezoeken <i>Ca. 556.000 per jaar</i>	
Effect van de usecase	5 minuten bespaarde tijd, zowel bij ontvangende als verzendende partij bij terugkoppeling van afwijzing aan verwijzer		In 83% van de gevallen kan de patiënt in 1 ^e lijn blijven		In 83% van de gevallen kan de patiënt in de 1 ^e lijn blijven		1% afname polikliniekbezoeken als gevolg van inzet tweewegcommunicatie in zorgnetwerk	
Inclusie	Onderstaande inclusiepercentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)							
2024	0%		0%		0%		0%	
2025	5%		0%		0%		0%	
2026	10%		10% ³		10% ³		10%	
Zorgkosten (in EUR 1000) of FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE
Impact 2024	0	x	0	x	0	x	0	X
Impact 2025	22	x	2,480	x	496	x	598	X
Impact 2026	45	x	5,143	x	1,066	x	1,239	X
Cum. impact t/m 2026	67	x	7.623	x	1,525	x	1,837	x
1 potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken								
3) Aanname is dat deze use-cases over de jaren voor max. 20% zullen bijdragen aan behalen totale effect, aangezien dit voortbouwt op lopende projecten								

1.1	Thema	1.2	Thema
	Digitale en Digitaalveranderende Medische en Paramedische Praktijken, de Veranderende Rol van de Zorgverzekering en de Zorgaanbieder		Dossier Inzage en Digitale Overdracht van (Acute) Zorg
	1.1.1 Medische Praktijk		2.1 Basisgegevens Zorg Medisch Specialistische Zorg
	1.1.2 Medische Praktijk		2.2 Medische Overdracht
	1.1.3 Medische Praktijk		2.3 Verpleegkundige Overdracht (Verpleegkundige)
	1.1.4 Medische Praktijk		2.4 Acute zorg
	1.1.5 Medische Praktijk		2.5 Acute zorg
	1.1.6 Medische Praktijk		2.6 Acute zorg
	1.1.7 Medische Praktijk		2.7 Acute zorg
	1.1.8 Medische Praktijk		2.8 Acute zorg
	1.1.9 Medische Praktijk		2.9 Acute zorg
	1.1.10 Medische Praktijk		2.10 Acute zorg
	1.1.11 Medische Praktijk		2.11 Acute zorg
	1.1.12 Medische Praktijk		2.12 Acute zorg
	1.1.13 Medische Praktijk		2.13 Acute zorg
	1.1.14 Medische Praktijk		2.14 Acute zorg
	1.1.15 Medische Praktijk		2.15 Acute zorg
	1.1.16 Medische Praktijk		2.16 Acute zorg
	1.1.17 Medische Praktijk		2.17 Acute zorg
	1.1.18 Medische Praktijk		2.18 Acute zorg
	1.1.19 Medische Praktijk		2.19 Acute zorg
	1.1.20 Medische Praktijk		2.20 Acute zorg
	1.1.21 Medische Praktijk		2.21 Acute zorg
	1.1.22 Medische Praktijk		2.22 Acute zorg
	1.1.23 Medische Praktijk		2.23 Acute zorg
	1.1.24 Medische Praktijk		2.24 Acute zorg
	1.1.25 Medische Praktijk		2.25 Acute zorg
	1.1.26 Medische Praktijk		2.26 Acute zorg
	1.1.27 Medische Praktijk		2.27 Acute zorg
	1.1.28 Medische Praktijk		2.28 Acute zorg
	1.1.29 Medische Praktijk		2.29 Acute zorg
	1.1.30 Medische Praktijk		2.30 Acute zorg
	1.1.31 Medische Praktijk		2.31 Acute zorg
	1.1.32 Medische Praktijk		2.32 Acute zorg
	1.1.33 Medische Praktijk		2.33 Acute zorg
	1.1.34 Medische Praktijk		2.34 Acute zorg
	1.1.35 Medische Praktijk		2.35 Acute zorg
	1.1.36 Medische Praktijk		2.36 Acute zorg
	1.1.37 Medische Praktijk		2.37 Acute zorg
	1.1.38 Medische Praktijk		2.38 Acute zorg
	1.1.39 Medische Praktijk		2.39 Acute zorg
	1.1.40 Medische Praktijk		2.40 Acute zorg
	1.1.41 Medische Praktijk		2.41 Acute zorg
	1.1.42 Medische Praktijk		2.42 Acute zorg
	1.1.43 Medische Praktijk		2.43 Acute zorg
	1.1.44 Medische Praktijk		2.44 Acute zorg
	1.1.45 Medische Praktijk		2.45 Acute zorg
	1.1.46 Medische Praktijk		2.46 Acute zorg
	1.1.47 Medische Praktijk		2.47 Acute zorg
	1.1.48 Medische Praktijk		2.48 Acute zorg
	1.1.49 Medische Praktijk		2.49 Acute zorg
	1.1.50 Medische Praktijk		2.50 Acute zorg
	1.1.51 Medische Praktijk		2.51 Acute zorg
	1.1.52 Medische Praktijk		2.52 Acute zorg
	1.1.53 Medische Praktijk		2.53 Acute zorg
	1.1.54 Medische Praktijk		2.54 Acute zorg
	1.1.55 Medische Praktijk		2.55 Acute zorg
	1.1.56 Medische Praktijk		2.56 Acute zorg
	1.1.57 Medische Praktijk		2.57 Acute zorg
	1.1.58 Medische Praktijk		2.58 Acute zorg
	1.1.59 Medische Praktijk		2.59 Acute zorg
	1.1.60 Medische Praktijk		2.60 Acute zorg
	1.1.61 Medische Praktijk		2.61 Acute zorg
	1.1.62 Medische Praktijk		2.62 Acute zorg
	1.1.63 Medische Praktijk		2.63 Acute zorg
	1.1.64 Medische Praktijk		2.64 Acute zorg
	1.1.65 Medische Praktijk		2.65 Acute zorg
	1.1.66 Medische Praktijk		2.66 Acute zorg
	1.1.67 Medische Praktijk		2.67 Acute zorg
	1.1.68 Medische Praktijk		2.68 Acute zorg
	1.1.69 Medische Praktijk		2.69 Acute zorg
	1.1.70 Medische Praktijk		2.70 Acute zorg
	1.1.71 Medische Praktijk		2.71 Acute zorg
	1.1.72 Medische Praktijk		2.72 Acute zorg
	1.1.73 Medische Praktijk		2.73 Acute zorg
	1.1.74 Medische Praktijk		2.74 Acute zorg
	1.1.75 Medische Praktijk		2.75 Acute zorg
	1.1.76 Medische Praktijk		2.76 Acute zorg
	1.1.77 Medische Praktijk		2.77 Acute zorg
	1.1.78 Medische Praktijk		2.78 Acute zorg
	1.1.79 Medische Praktijk		2.79 Acute zorg
	1.1.80 Medische Praktijk		2.80 Acute zorg
	1.1.81 Medische Praktijk		2.81 Acute zorg
	1.1.82 Medische Praktijk		2.82 Acute zorg
	1.1.83 Medische Praktijk		2.83 Acute zorg
	1.1.84 Medische Praktijk		2.84 Acute zorg
	1.1.85 Medische Praktijk		2.85 Acute zorg
	1.1.86 Medische Praktijk		2.86 Acute zorg
	1.1.87 Medische Praktijk		2.87 Acute zorg
	1.1.88 Medische Praktijk		2.88 Acute zorg
	1.1.89 Medische Praktijk		2.89 Acute zorg
	1.1.90 Medische Praktijk		2.90 Acute zorg
	1.1.91 Medische Praktijk		2.91 Acute zorg
	1.1.92 Medische Praktijk		2.92 Acute zorg
	1.1.93 Medische Praktijk		2.93 Acute zorg
	1.1.94 Medische Praktijk		2.94 Acute zorg
	1.1.95 Medische Praktijk		2.95 Acute zorg
	1.1.96 Medische Praktijk		2.96 Acute zorg
	1.1.97 Medische Praktijk		2.97 Acute zorg
	1.1.98 Medische Praktijk		2.98 Acute zorg
	1.1.99 Medische Praktijk		2.99 Acute zorg
	1.1.100 Medische Praktijk		2.100 Acute zorg

Verdieping Thema 2: Dossier Inzage en Digitale Overdracht van (Acute) Zorg, ter ondersteuning van de basis op orde



Elektronische gegevensuitwisseling voor Dossier Inzage en Digitale Overdracht van (Acute) Zorg

Om goed in te kunnen spelen op de stijgende zorgvraag en stijgende complexiteit van de zorgvraag is het belangrijk dat partijen in het netwerk rondom de inwoner, samen met de inwoner en elkaar goed en effectief samenwerken. Om samen te kunnen werken is beschikbaarheid en het delen van informatie essentieel. Dat is waar Trijn de digitaliseringsopgave in de regio ondersteunt. Thema 2 gaat over het beschikbaar stellen van relevante dossierinformatie en informatie die nodig is bij overdracht van zorg over de domeinen heen. De usecases, netwerkzorg viewer én het fundament dragen bij aan het beschikbaar stellen van deze data.

Elke organisatie en/of professional in het netwerk van zorg en welzijn houdt een apart dossier bij voor een inwoner of patiënt. Registratie vindt plaats in silo's binnen de kaders van een organisatie en volgens een specifieke ordening passend bij het domein en/of professie. Nog steeds verlopen de stromen van communicatie en gegevensuitwisseling veelal via telefonisch contact, papieren brieven met de patiënt mee, veilige mail, point to point uitwisseling met een ingesloten PDF. Hierdoor is het nodig dat elke organisatie of professional opnieuw de actuele informatie uitvraagt bij de inwoner. Als gevolg leidt dit nog steeds tot veel onnodige extra tijd, foutgevoeligheid en frustratie in het proces.

Daarnaast is er géén uniform werkproces voor het overdragen van patiënten en is afwijkend per type overdracht. Door dossier inzage en digitale overdracht van zorg mogelijk te maken, kan deze informatie direct ingezien worden (raadplegen) en zo mogelijk worden hergebruikt, waardoor er minder administratieve lasten zijn en de zorg efficiënter geleverd kan worden.

Het realiseren van een gedragen regionale data- en applicatie architectuur en technische inrichting van de digitale omgeving op basis van landelijke standaarden. Voor het beschikbaar stellen van de data in de bronsystemen, worden specifieke specifieke RTA's voor dossier inzage en digitale overdracht incl. gestructureerde registratie aan de bron ontwikkeld. Deze RTA's sluiten aan op de landelijke (informatie) standaarden, welke geprioriteerd zijn onder Wegiz. De werkprocessen worden gesteund door data beschikbaarheid en het op orde brengen van de basis. De vijf geprioriteerde gegevensdiensten onder Wegiz. Vervolgens realiseren van de infrastructuur (incl. integratie met landelijke generieke functies) volgens de plateau planning.

De usecases 2.1 t/m 2.4 dragen bij aan de standaardisatie van de datasets, welke voorwaardelijk is voor het gestructureerd beschikbaar stellen van deze data via usecase 2.5, de netwerkzorg viewer en bijbehorende digitale zorgtoepassingen als het 360-graden beeld van een inwoner, het actuele medicatie overzicht en de proactieve zorgplanning voor passende zorg met inzichtelijke behandelwensen en beperkingen.



Introductie Thema 2: Dossier inzage en digitale overdracht van (Acute) Zorg binnen het netwerk

De reis van Theo in relatie tot de use cases en het fundament



Persona Theo

- Leeftijd: 82
- Was getrouwd met Greet, zij is een jaar geleden overleden
- Theo is in slechte conditie, licht dementerend en heeft thuiszorg
- Hij is dol op het contact met zijn kinderen en kleinkinderen en houdt van vissen

Reis van Theo

1. De mantelzorger belt 112 omdat Theo niet lekker wordt. Theo wordt opgehaald door een ambulance
2. Het ziekenhuis constateert een hersenbloeding bij Theo. Na eerste opvang in het ziekenhuis wordt hij tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum
3. Tijdens zijn revalidatietraject wordt medicatie voorgeschreven en overleg gepleegd met de behandelend arts uit het ziekenhuis
4. Vanuit het revalidatiecentrum wordt Theo tijdelijk opgenomen in een verpleeghuis
5. Na zijn revalidatie gaat Theo thuis wonen, ondersteund door een wijkverpleegkundige
6. Na verloop van tijd merken de wijkverpleegkundige, huisarts, Theo's familie en hij zelf dat thuis wonen niet meer gaat. Theo verhuist naar een verpleeghuis waar hij de rest van zijn leven zal wonen
7. Tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis wordt hulp vanuit een GGZ instelling ingeschakeld omdat Theo agressief gedrag vertoont. Daarbij krijgt Theo last van een hoge bloeddruk, waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medicatie voorschrijft

Use cases Thema 2

2.4 Acute zorg

Gegevensuitwisseling conform richtlijn Acute Zorg

2.1 Medische overdracht

Basis patiëntgegevens voor medisch specialistische zorg

2.2 Medicatie overdracht

Medicatiegegevens, laboratorium gegevens en contra indicaties en overgevoeligheden

2.3 Verpleegkundige overdracht

eOverdracht

Fundament

Het fundament maakt inzage in het dossier van Theo mogelijk door real time data uit de verschillende bronsystemen binnen het netwerk op te halen en vervolgens te presenteren. Middels één digitale voordeur kan Theo zelf zijn dossier inzien en aanpassen waar nodig. (Zorg-) Professionals kunnen vanuit hun eigen systeem het dossier van Theo



Usecase 2.1 – Medische Overdracht (Basisgegevensset Zorg Medisch Specialistische Zorg)



Medische Overdracht – Ambitie

Implementeren en adopteren van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ), volgens de wettelijke bepaling, ten behoeve van de continuïteit, effectiviteit en efficiëntie van zorg.



Kernproblematiek

- Hoge administratielast door dubbel invoeren, extra controles door onvolledige informatie, het ongestructureerd ontvangen van data.
- Incorrecte behandeling van de inwoner door het niet hebben van volledige, juiste of meest recente informatie van de inwoner.
- Lagere kwaliteit zorg door het ontbreken van een gestructureerd overzicht bij verwijzing of informatie opvraag, waardoor het langer duurt tot de juiste zorg geleverd kan worden.
- Onnodig hoge vraaglast voor de inwoner, omdat meermaals om dezelfde informatie wordt gevraagd.

Link IZA-opgaven

- **Betere patiëntervaring:** minder herhaling van uitvraag tijdens anamnese, intake, etc.
- **Lagere zorgkosten:** snellere, efficiëntere opname ongeplande zorgsituatie.
- **Behoud zorgprofessionals:** afname administratieve druk, efficiëntie en tijdsbesparing bij het verkrijgen, registreren en verifiëren van de (zorg-)informatie
- **Verbeteren zorguitkomsten:**, continuïteit en mogelijk voorkomen van fouten door inzicht in medicatie en allergieën.



Huidige situatie

De digitale gegevensuitwisseling voor de BgZ binnen de MSZ is nog niet volledig geadopteerd, waardoor zorgprofessionals vaak niet over voldoende, juiste en actuele informatie beschikken en soms gegevens handmatig moeten invoeren, wat leidt tot hogere werkdruk en gebrek aan continuïteit in de zorg. Met 36.000 medische overdrachten en 275.000 opvragingen valt hier nog veel winst te halen. De samenwerking tussen zorgprofessionals mist instelling-overstijgende werkafspraken. Ziekenhuizen hebben VIPP5 doorlopen, maar voldoen nog niet aan de NEN 7540 (inclusief TA Notified Pull) en/of moeten nog overstappen op FHIR voor gegevensuitwisseling. Tot slot is met VIPP5 de BgZ alleen geïmplementeerd in ziekenhuizen; de klinieken in de regio hebben deze stap nog niet gezet.



Ambitie, eind 2026:

- We faciliteren de continuïteit van de zorg tijdens de medische overdracht door informatie op te vragen en medisch specialisten te ondersteunen bij het vastleggen, delen en verwerken in het eigen systeem van BgZ-gegevens.
- Dit realiseren we door de BgZ-gegevensuitwisseling op te zetten. Dit omvat een beknopte samenvatting, oftewel de minimale set van (medische) patiëntgegevens die relevant is voor verschillende specialismen, ziektebeelden en beroepsgroepen, essentieel voor de continuïteit van zorg. De BgZ speelt een cruciale rol in elk aspect van het geplande of ongeplande zorgproces en biedt medisch specialisten inzicht in de toestand van de patiënt op een bepaald moment.
- Tegen eind 2025 kunnen MSZ-instellingen de BgZ en relevante correspondentie digitaal verzenden en ontvangen, gebaseerd op de TA Notified Pull en het Twiin Afsprakenstelsel. Ze voldoen ook aan de kwaliteitsstandaard BgZ (procesafspraken), de informatiestandaard BgZ en de NEN 7540.
- Dit alles leidt tot tijdsbesparing voor zorgprofessionals en betere zorguitkomsten door de verbeterde continuïteit van zorg binnen de MSZ.



Doorontwikkeling, na 2026:

1. We ondersteunen de gestandaardiseerde uitwisseling van BgZ-gegevens binnen de MSZ, ook in andere zorgsectoren en het sociaal domein.
2. Applicaties en zorg kennen geen grenzen, dus het is belangrijk om internationale standaarden te volgen, zoals de European Patient Summary (EPS) in de EHDS.
3. Daarnaast kunnen BgZ-gegevens en hun gebruik waardevol zijn voor secundaire doeleinden, zoals onderzoek en kwaliteitsverbetering.



Medische Overdracht – Projectfasering

Na het concretiseren en inrichten, starten ziekenhuizen met de verdere technische realisatie van de BgZ-gegevensstandaard conform 7540 en passen hun werkprocessen hierop aan.

Fase 1
Q2 2025 - Q3 2025

Fase 2*
Q4 2025 - Q1 2026

Fase 3
Q2 2026 - Q3 2026

Fase 4
Q3 2026 - Q4 2026

Concretiseren en inrichten

Concretiseren van regionaal beleid, visie, intentieverklaring en werkafspraken vanuit alle instellingen.

Verkrijgen van inzicht in deelnemende klinieken, lopende programma's en initiatieven, gebruikte applicaties en stand van zaken binnen de zorginstellingen t.o.v. realisatie BgZ met volwassenheidsscan.

We definiëren en maken de technische en functionele inrichting van systemen klaar.

- Alle MSZ-instellingen en projectteam

Doelgroepen

- Kick-off
- Koplopers ziekenhuizen (UMC Utrecht, Diaconessenhuis)

- Evaluatie en optimaliseren uitrol
- Volger ziekenhuizen (St. Antonius Ziekenhuis)
- Koplopers klinieken

- Voorbereiding opschaling
- Volgers klinieken

Technisch gereed

- Implementatie conform NEN 7540



BgZ technisch gerealiseerd bij koplopers ziekenhuizen

- Implementatie conform NEN 7540



BgZ technisch gerealiseerd bij volger ziekenhuizen en koplopers klinieken

- Implementatie conform NEN 7540



BgZ technisch gerealiseerd bij alle ziekenhuizen en klinieken

Procesmatig gereed

- Opstellen regionale werkafpraak medische overdracht.



Werkafpraak medische overdracht gepubliceerd

- Adoptie nieuw proces A) verwijzen en B) opvragen.



BgZ opgenomen in werkproces koplopers en volgers

- Adoptie nieuw proces A) verwijzen en B) opvragen.



BgZ opgenomen in werkproces alle ziekenhuizen en klinieken

Activiteiten

Deliverables

Meander MC is bezig met een Hix implementatie en zal niet deze fasering kunnen volgen. Wij zullen aansturen op correct gebruik van de BgZ met Hix vanaf de implementatie

*Echte start datum hangt af van Chipsoft



Medische Overdracht – Impact

Getallen zijn indicatief en
worden nog gevalideerd!!

Regionale tijdswinst door verzenden en ontvangen medische overdracht in 2026 meer dan 3 miljoen per jaar, ofwel 30 FTE



Kwalitatieve impact¹

1

- We verbeteren de kwaliteit van zorg voor de inwoner door volledige informatie te hebben.
- De zorgverlening loopt efficiënter door gestructureerd inzicht in de overdracht voor zorgprofessional.
- Inwoners krijgen een passend zorgplan, omdat alle benodigde informatie beschikbaar is.

2

- Inwoners krijgen sneller de juiste zorg.
- Inwoners en hun naasten ervaren minder ongemak, omdat ze hun verhaal minder vaak hoeven te herhalen en de overdracht digitaal gebeurt
- Inwoners ervaren een soepele overgang tussen zorgorganisaties, omdat de zorgverlener zich al kan voorbereiden op de benodigde zorg.

3

- Zorgverleners hebben meer tijd voor echte zorg in plaats van administratie en nabellen.
- Zorgverleners zoeken minder naar de juiste informatie en hebben minder onzekerheid over het zorgplan.
- Zorgverleners kunnen de zorg beter voorbereiden.

4

- Digitale aanvragen en een gestandaardiseerd overzicht van de overdracht besparen zorgprofessionals tijd, die ze aan zorgtaken kunnen besteden.
- We voorkomen verkeerde behandelingen, dubbele diagnostiek, onnodige heropnames en verspilling van materiaal door missende of foutieve informatie, wat leidt tot minder uitgaven.

Kwantitatieve impact 2

Doelgroep	Alle medische overdrachten in regio Midden-Nederland; ca. 36.000 per jaar		Alle medische overdrachten in regio Midden-Nederland; ca. 36.000 per jaar		Alle medische dossiers waar medische inzage kan worden opgevraagd; ca. 275.000 per jaar	
Effect van de usecase medische overdracht	Per verzending - 5 min medische secr. voor het klaarzetten van informatie - 3 min medisch specialist voor het controleren van de informatie		Per ontvangst , 5 min medisch specialist bij het overnemen van informatie In 10% gevallen , 8 min medisch specialist door voorkomen van aanvullende diagnoses		Per verzending - 5 min medische secr. voor bij elkaar zoeken informatie - 3 min medisch specialist controleren van informatie In 10% gevallen , 8 min medisch specialist door voorkomen van aanvullende diagnoses	
Onderstaande inclusiepercentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)						
Inclusie						
2024	0%		0%		0%	
2025	50%		50%		50%	
2026	100%		100%		100%	
Zorgkosten ³ (Z) of FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE
Impact 2024	0	0	0	0	0	0
Impact 2025	129	1,5	163	1,1	1.172	12,6
Impact 2026	267	3,0	338	2,2	2.430	25,4
Cum. impact t/m 2026	396	4,5	501	3,2	3.602	38,0

van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken

3) x € 1.000

Usecase 2.2 – Medicatie Overdracht



Medicatieoverdracht – Ambitie

Implementeren en adopteren van de Medisch Overdracht (MP9), labresultaten, contra-indicaties en overgevoeligheden volgens de wettelijke bepaling, ten behoeve van de continuïteit, effectiviteit en efficiëntie van zorg.



Kernproblematiek

- Medicatie-incidenten: Onvoldoende informatievoorziening kan leiden tot incorrecte medicatiegegevens wat kan leiden tot medicatie incidenten, (her) opnames en mortaliteit.
- Tijdverspilling: Zorgverleners zijn veel onnodige tijd kwijt aan recepten en verificatie.
- Frustratie bij inwoners: Door niet goed afgestemde systemen moeten inwoners meerdere keren aan verschillende zorgverleners hetzelfde verhaal vertellen
- Stroeve samenwerking en geremde innovatie: Er zijn vele zorgverleners in de regio, veelal met verschillende werkprocessen, verschillend gebruik van terminologie en met uiteenlopende systemen, zonder inzicht in elkaars medicatieproces.

Link IZA-opgaven

- **Optimaal inzetten van capaciteit en inzetten op elektronische gegevensuitwisseling;** Als zorgverleners minder tijd nodig hebben voor het opvragen en verifiëren van medicatie- en labgegevens, blijft er meer tijd en energie over voor andere werkzaamheden. Deze use case draagt eraan bij dit op een elektronische manier te doen.
- **Verminderen administratieve lasten en behouden van beschikbare zorgprofessionals;** Zorgprofessionals besteden minder tijd aan onnodige administratie en dit draagt bij aan het vergroten van het werkplezier.
- **Verbeteren zorguitkomsten;** Minder foutieve of suboptimale medicatie draagt bij aan verbeterde zorguitkomsten voor inwoners.



Huidige situatie

- Zorgorganisaties en professionals, waaronder apotheken en diagnostische centra, houden ieder aparte dossiers bij voor inwoners/patiënten/cliënten. Zij slaan daar medicatie- en labgegevens op binnen hun organisatie en op hun eigen manier.
- Gegevensuitwisseling vindt beperkt plaats. Hierdoor moeten zorgorganisaties geregeld actuele informatie opnieuw onderling of bij inwoners uitvragen.
- Er is in de regio géén uniform werkproces voor handelingen rondom medicatieverstrekking, het voorschrijven van medicatie en het overdragen.



Ambitie, eind 2026:

- In voorbereiding op de implementatie van MP9 worden de regionale werkprocessen in kaart gebracht en daarmee de verschillen en problemen tussen de organisaties aangetoond (gap-analyse). Met dit als basis worden, via het Platform RTA, de regionale werkafspraken omtrent medicatieoverdracht en het uitwisselen van labgegevens herzien zodat men effectiever met elkaar samen kan werken.
- Om voor te sorteren op de implementatie van MP9 creëren we in de regio eenheid van taal voor medicatie, intoleranties en overgevoeligheden, en contra-indicaties. Dit omvat: doseringsinformatie (WCIA25-tabel waar relevant) en de opvolger van de WCIA25-tabel waar relevant, G-standaard, referentieset allergieën en referentieset contra-indicaties o.b.v. SNOMED, labcodeset o.b.v. LOINC/UCUM.
- In de regio realiseren we, in voorbereiding op de volledige implementatie van MP9, Lab2Zorg en CiO, technische aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP). We houden aansluiting met de landelijke lijn en starten wanneer mogelijk met het implementeren van de MP9, Lab2Zorg en CiO standaarden.



Doorontwikkeling, na 2026:

- In navolging van de koploperregio's: Uitwisselen van medicatie- en labgegevens tussen organisaties conform kwaliteits- en informatiestandaard voor Medicatie Overdracht (MP9, Lab2zorg, en CiO) en hiermee voldoen aan de Wegiz-standaard.
- Bijbehorende werkafspraken in de keten zijn geïmplementeerd.
- Betrokken zorgorganisaties voldoen aan [NEN7503](#) en [NEN7542](#).



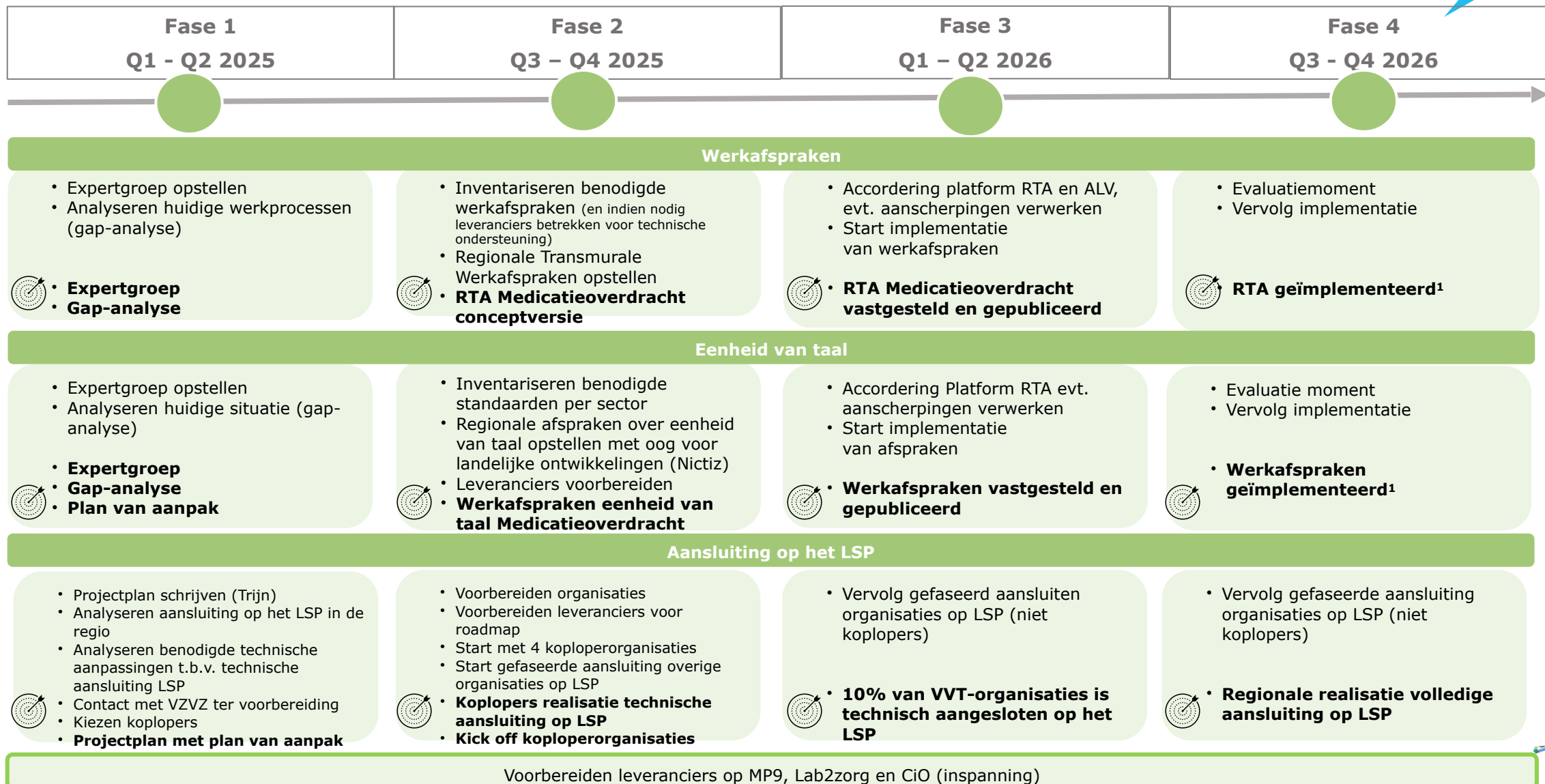
Medicatie Overdracht – Projectfasering



= **deliverable: Wat leveren we op**

Voortborduren op de ervaring uit kickstartregio's

1. De werkafspraken die nog niet direct gelinkt zijn aan de toepassing van de MP9, Lab2Zorg en CiO zijn geïmplementeerd. De specifieke werkafspraken voor MP9, Lab2Zorg en CiO zijn voorbereid en worden geïmplementeerd tijdens de uitrol.





Medicatieoverdracht – Impact

Getallen zijn indicatief en
worden nog gevalideerd!!

Regionale tijdswinst door verzenden en ontvangen medicatieoverdracht in 2026 meer dan 9 miljoen per jaar



Kwalitatieve impact¹

1

- Verbetering van kwaliteit van zorg door vermeden ziektelasten voor inwoners

2

- Minder herhaling van vragen van zorgverleners gedurende het zorgtraject
- Meer vertrouwen in zorg omdat reeds eerder verstrekte informatie bekend is bij zorgprofessional
- Soepelere overgang tussen zorgverleners voor inwoners

3

- Meer tijd voor zorgtaken door minder administratie en meer eenheid van taal.
- Beter inzicht in totale medicatiegebruik, ook wat door andere zorgverleners is voorgeschreven, verstrekt of is gewijzigd. Dit faciliteert betere samenwerking in de zorgketen tussen zorgverleners.
- Minder werkgerelateerde stress en meer plezier voor zorgprofessionals, aangezien er minder (telefonisch) contact nodig is om inzicht te krijgen in medicatie van een inwoner. Zorgprofessionals hebben ook meer vertrouwen in de informatie die zij hebben/krijgen.

4

- Betere kwaliteit van behandeling, met als gevolg onder andere minder dubbele voorschriften of medicatieverspilling door inzage in actuele gegevens.
- Zorgprofessionals zijn per saldo minder tijd kwijt aan handelingen rond medicatie (voorschrijven, verstrekken, toedienen) omdat zij minder tijd kwijt zijn aan het verifiëren
- Minder zorghandelingen zoals ziekenhuisopnames of consulten bij huisartsen, instellingsartsen of de spoedeisende hulp door afname incidenten

Kwantitatieve impact ²

Doelgroep	Aantal ziekenhuisopnames door medicatie-incidenten <i>ca. 4.900 per jaar</i>		Aantal medicatie-incidenten; <i>ca. 7.400 per jaar</i>		Aantal contactmomenten m.b.t. medicatie-gebruik <i>ca. 20 miljoen per jaar</i>	
Effect van de usecase medicatie-overdracht	13% minder medicatie-incidenten die leiden tot ziekenhuisopnames		50% minder potentieel vermijdbare indicatie-incidenten – die niet leiden tot ziekenhuisopname –maar wel tot hogere zorgkosten leiden		Ca. 1.12 minuten minder tijd nodig per contactmoment m.b.t. medicatiegebruik	
Onderstaande inclusiepercentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)						
Inclusie						
2024	0%		0%		0%	
2025	10%		10%		10%	
2026	30%		30%		30%	
Zorgkosten ³ (Z) of FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE
Impact 2024	0	0	0	0	0	0
Impact 2025	479	x	67	x	2.356	x
Impact 2026	1.491	X	209	X	7.330	X
Cum. impact t/m 2026	1.970	x	277	x	9.686	x

- 1) De kwalitatieve impact is beschreven aan de hand van de quadruple aim model, waarin de impact op (1) gezondheidsuitkomsten, (2) inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredenheid en (4) zorgkosten is beschreven
- 2) Disclaimer: Voor de impactanalyse zijn alleen zorgorganisaties in de huidige scope meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken
- 3) x € 1.000



Usecase 2.3 – Verpleegkundige Overdracht (eOverdracht)



Verpleegkundige Overdracht – Ambitie

Implementeren van de eOverdracht-informatiestandaard volgens de wettelijke bepaling, voor gegevensuitwisseling tussen organisaties, voor betere zorguitkomsten, meer continuïteit van zorg en tijdsbesparing.



Kernproblematiek

- Zorgprofessionals ervaren hoge administratieve last door dubbel invoeren, extra controles door onvolledige informatie en het ongestructureerd ontvangen van data.
- De inwoner krijgt niet-passende behandeling door het niet hebben van volledige, juiste of meest recente informatie van de inwoner.
- Er wordt lagere kwaliteit van zorg geleverd door het ontbreken van een gestructureerd overzicht, waardoor zorg niet gepland kan worden of niet de juiste vragen gesteld kunnen worden aan de inwoner.
- Het veroorzaken van onnodig hoge vraaglast voor de inwoner en naasten, omdat er meermaals om dezelfde informatie wordt gevraagd.

Link IZA-opgaven

- **Verminderen administratieve lasten om zorgprofessionals te ontlasten;** minder handmatige dubbele registraties.
- **Behouden van beschikbare zorgprofessionals;** door vergroten werkplezier en meer tijdsbesteding aan zorg.
- **Inzetten op elektronische gegevensuitwisseling;** wettelijk bepaald.



Huidige situatie

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren amper de voordelen van digitale vastlegging en gegevensuitwisseling bij de verpleegkundige overdracht. Gegevens worden ongestructureerd opgeslagen in gescheiden systemen, wat leidt tot extra registratielast voor zorgprofessionals. Bovendien wisselen de systemen gegevens niet automatisch uit, waardoor verpleegkundigen en verzorgenden extra moeten uitzoeken en gegevens handmatig moeten overtypen bij de overdracht. Daarnaast is de overdracht vaak onvolledig, bevat veel overbodige informatie of ontbreekt zelfs volledig, wat dit een kwetsbaar onderdeel maakt in het zorgproces. Dit brengt risico's met zich mee voor de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de inwoner.



Ambitie, eind 2026:

- Het realiseren van de eOverdracht-gegevensuitwisseling; een veilige, gestandaardiseerde, gestructureerde en geautomatiseerde overdracht van verpleegkundige zorg op basis van zorginformatiebouwstenen (57 zibs). Met de Minimale eOverdracht (MeO) komen in eerste instantie 14 zibs + de overige zibs in PDF beschikbaar voor uitwisseling van bron naar bron. Vóór 2027 kunnen zorgorganisaties de eOverdracht digitaal verzenden en beschikbaar stellen, opvragen/ontvangen, inzien en (al dan niet selectief) overnemen van het overdrachtsbericht.
- In de volgende richtingen: ZKH→VVT; VVT→VVT; VVT→ZKH; ZKH→ZKH; VVT→GGZ; GGZ→VVT
- We besparen tijd per overdracht in alle richtingen, wat we kunnen besteden aan directe zorg aan de inwoner. We verminderen ook de stressbelasting bij inwoners, mantelzorgers en zorgprofessionals.

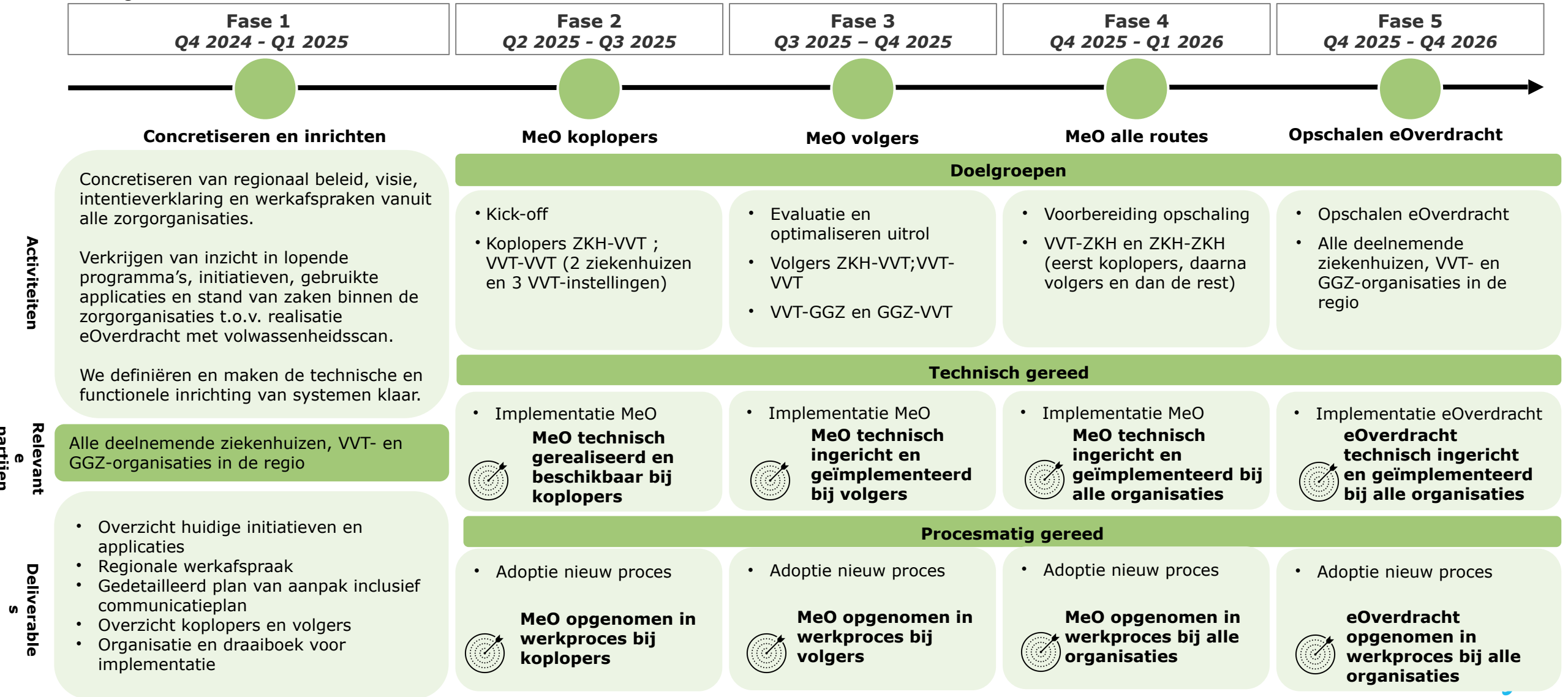


Doorontwikkeling, na 2026:

1. Gegevens worden secundair gebruikt voor onderzoek en kwaliteit voor procesoptimalisatie.
2. AI voorspelt hoe lang een inwoner bepaalde type zorg nodig heeft, waardoor capaciteit beter ingeschat wordt.
3. AI leert patronen uit gestandaardiseerde data en doet suggesties voor ingevulde velden, wat tijdswinst oplevert in het overdrachtsproces.
4. AI maakt een dossiersamenvatting, wat het dossier makkelijker te lezen maakt.

Verpleegkundige Overdracht – Projectfasering

Na het concretiseren en inrichten, starten koplopers met de Minimale eOverdracht, gevolgd door opschaling naar meer zorgorganisaties en de volledige eOverdracht.



Verpleegkundige Overdracht – Impact

Getallen zijn indicatief en worden nog gevalideerd!!

Regionale tijdswinst door uitwisseling van de eOverdracht in 2026, meer dan 1.1 miljoen per jaar, ofwel 14 FTE



Kwalitatieve impact¹

1

- We verbeteren de kwaliteit van zorg voor de inwoner door volledige informatie te hebben.
- De zorgverlening loopt efficiënter door gestructureerd inzicht in de overdracht voor zorgprofessional.
- Inwoners krijgen een passend zorgplan, omdat alle benodigde informatie beschikbaar is.

2

- Inwoners krijgen sneller de juiste zorg.
- Inwoners en hun naasten ervaren minder ongemak, omdat ze hun verhaal minder vaak hoeven te herhalen en de overdracht digitaal gebeurt
- Inwoners ervaren een soepele overgang tussen zorgorganisaties, omdat de zorgverlener zich al kan voorbereiden op de benodigde zorg.

3

- Zorgverleners hebben meer tijd voor echte zorg in plaats van administratie en nabellen.
- Zorgverleners zoeken minder naar de juiste informatie en hebben minder onzekerheid over het zorgplan.
- Zorgverleners kunnen de zorg beter voorbereiden.

4

- Digitale aanvragen en een gestandaardiseerd overzicht van de overdracht besparen zorgprofessionals tijd, die ze aan zorgtaken kunnen besteden.
- We voorkomen verkeerde behandelingen, dubbele diagnostiek, onnodige heropnames en verspilling van materiaal door missende of foutieve informatie, wat leidt tot minder uitgaven.
- Verlagen kosten zorgmiddelen en papier.

Kwantitatieve impact²

Doelgroep		# Verpleegkundige overdrachten van en naar het ziekenhuis		# Verpleegkundige overdrachten van en naar de VVT		# Verpleegkundige overdrachten van en naar de GGZ		# Heropnames in het ziekenhuis	
Effect van realisatie verpl. Overdracht		10 min tijdswinst bij verzending, 15 min tijdswinst bij ontvangst		5 min tijdswinst bij verzending, 60 min tijdswinst bij ontvangst		5 min tijdswinst bij verzending, 34 min tijdswinst bij ontvangst		Afname van heropnames met 1%	
		Onderstaande inclusiepercentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)							
Inclusie		Verzenden	Ontvangen	Verzenden	Ontvangen	Verzenden	Ontvangen		
2024		0	0	0	0	0	0	0	
2025		30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	
2026		100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
Zorgkosten ³ (Z) of FTE		Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE
Impact 2024		0	0	0	0	0	0	0	0
Impact 2025		107	1,2	181	3,0	108	1,8	7	0,01
Impact 2026		224	2,3	380	6,2	228	3,7	12	0,02
Cum. impact t/m 2026		331	3,5	561	9,2	336	5,5	19	0,03

inwonertevredenheid, (3) zorgprofessionaltevredeheid en (4) zorgkosten is beschreven

2) Disclaimer: Voor de impactanalyse zijn alleen zorgorganisaties in de huidige scope meegenomen. Dit vertegenwoordigt de ondergrens van de potentiële scope, aangezien er mogelijkheden zijn om een breder zorglandschap te betrekken

3) x € 1.000



Usecase 2.4 – Databeschikbaarheid in acute zorg



Databeschikbaarheid in de acute zorg – Ambitie

Naast het implementeren van (selectieve) berichten en gegevensuitwisseling in het netwerk acute zorg volgens de wettelijke bepaling, ligt de focus op het beschikbaar kunnen stellen van (acute zorg) data, voor betere continuïteit en uitkomsten van zorg.



Kernproblematiek

- Veel zorgorganisaties houden aparte dossiers bij, wat leidt tot een gebrek aan uniform inzicht in relevante en actuele patiëntgegevens
- Er is behoefte aan digitale gegevensuitwisseling in de gehele acute zorgketen. Het gebrek aan een gestandaardiseerde regionale data-architectuur, versnipperde terminologie, en strenge (wettelijke) eisen omtrent privacy en beveiliging, bemoeilijken deze uitwisseling.
- Er is onvoldoende inzicht in het behandelbeleid en de wensen van patiënten, wat essentieel is voor proactieve zorgplanning.

Link IZA-opgaven

- **Verminderen administratieve lasten om zorgprofessionals te ontlasten:** minder nabellen en handmatige stappen om verificatie te doen
- **Behouden van beschikbare zorgprofessionals:** door vergroten werkplezier en meer beschikbare tijd voor zorg.
- **Inzetten op elektronische gegevensuitwisseling;** betere zorgcoördinatie en interoperabiliteit voor een toekomstbestendig en efficiënter zorgsysteem.



Huidige situatie

In de acute zorg is het zeer belangrijk dat zorgverleners toegang hebben tot relevante patiëntgegevens. Zeker in acute situaties moet dit snel en overzichtelijk beschikbaar zijn.

De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn is in het Integraal Zorg Akkoord toegevoegd aan de lijst van prioritaire gegevensuitwisselingen.

Gegevensuitwisseling in de acute keten vindt nog veelal plaats middels telefonisch contact of papieren brieven. Hierdoor moeten zorgorganisaties geregeld actuele informatie opnieuw uitvragen onderling of bij inwoners/patiënten. Dit leidt tot onnodige extra tijd en administratie, foutgevoeligheid en frustratie.



Ambitie, eind 2026:

- Relevante data die beschikbaar is vanuit één bron. Nu zijn er soms verschillende databronnen die op inhoud niet overeenkomen.
- Zoveel mogelijk digitale overdracht en verwijzing met kloppende data, tussen stakeholders uit de acute zorgketen.
- Praten in eenheid van taal: gegevens vastleggen en uitwisselen via dezelfde (informatie)standaarden.
- Praten in eenheid van techniek: registreren en raadplegen in hetzelfde platform (i.p.v. PDF en telefonische overdrachten).
- Informatie mag niet verloren gegaan tussen stappen in het zorgproces en en bij overdrachten. Het moet niet in aparte dossiers opgeslagen blijven, zoals huisartsendossier. En er moet vanuit zorgverleners en -organisaties commitment zijn om data beschikbaar te stellen.
- Focus op de informatiebehoefte van de ontvanger, inzicht in capaciteit2 voor snelle doorverwijzing.
- Het verwijderen van de muren van kantoortijden: tijdstip moet geen invloed hebben op databeschikbaarheid (kantooruren vs. ANW-uren)
- Er is een wens voor een centraal punt in de GGZ van waaruit regio's informatie kunnen verkrijgen. Oftewel regio-breed toegang tot GGZ-informatie voor crisisdiensten en andere GGZ-instellingen.

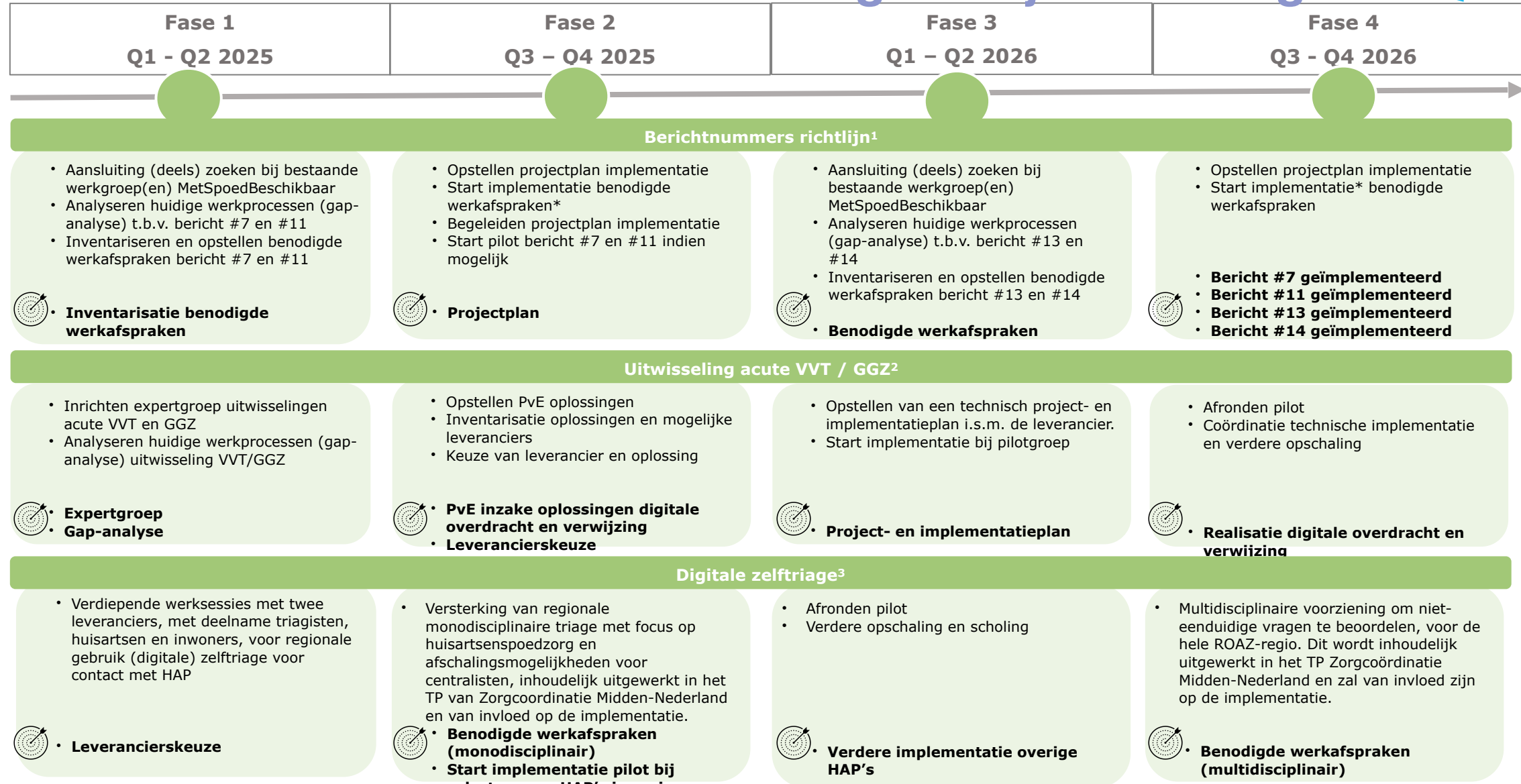


Doorontwikkeling, na 2026:

- Een selectie van bericht-nummers. Er komt vanuit MetSpoed-Beschikbaar een rationalisatieslag om definitieve berichtnummers te bepalen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Berichtnummers 7, 11, 13 en 14 zullen worden geïmplementeerd.
- Acute VVT & GGZ: Opschaling naar betrekking digitale beschikbaarheid patiëntgegevens.
- Digitale zelftriage: Verdere multidisciplinaire opschaling



Databeschikbaarheid in de acute zorg – Projectfasering



1. Werkafspraken worden opgesteld ter ondersteuning van de technische implementatie van de berichtnummers vanuit MetSpoedBeschikbaar
2. Nictiz zal ook gaan starten met een verkenning rond de aansluiting van acute VVT en GGZ bij MetSpoedBeschikbaar/berichtnummers richtlijn. Dit wordt in de loop van 2025 opgeleverd.
3. Projectopdracht wordt opgesteld als onderdeel van transformatieplan Zorgcoördinatie Midden-Nederland en er is daarom onderlinge afhankelijkheid met die planning.

Acute Zorg – Impact

Getallen zijn indicatief en
worden nog gevalideerd!!

.....

Kwalitatieve impact¹

- Verbetering van kwaliteit van zorg door nauwkeurige overdracht van informatie wat leidt tot snellere en gerichte interventies
- Vermindering van ziektelasten door adequaat ingrijpen op basis van volledige patiënt informatie.
- Minder herhaling van vragen van zorgverleners gedurende het zorgtraject
- Patiënten ervaren minder vertragingen bij verwijzingen en behandelingen, doordat gegevensuitwisseling soepel verloopt tussen betrokken zorgverleners
- Betere informatievoorziening aan patiënten en naasten: Door goede gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners sneller en accurater antwoord geven op vragen van patiënten en hun familie. Dit verhoogt het vertrouwen en de tevredenheid van patiënten over de zorg die ze ontvangen.
- Minder administratieve druk door gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en meer tijd voor zorgtaken door minder administratie
- Beter samenwerken in multidisciplinaire teams:). Door uniforme gegevensstandaarden en toegang tot dezelfde data, kunnen verschillende teams efficiënter samenwerken en communiceren.
- Gemakkelijkere toegang tot relevante informatie vanuit één bron, wat leidt tot minder frustraties over verouderde systemen, en minder (telefonisch) contact tussen zorgverleners.
- Minder herhaalde onderzoeken en procedures, doordat gegevens niet verloren gaan en toegankelijk blijven voor alle betrokken partijen
- Efficiëntere zorgketen met minder tijdsverlies door geautomatiseerde digitale overdracht, resulterend in minder administratieve lasten en kostenbesparing
- Doordat er betere zorg verleend wordt voorkomt dat onnodige gezondheidsschade en ook zorgkosten

Kwantitatieve impact ²										
Doelgroep	Tijdsbesparing acute situaties van/naar VVT en GGZ tijdens ANW-uren <i>ca. 4.200 per jaar</i>		Tijdsbesparing door impl. MSB berichtnr. 7, 11, 13 , 14³ <i>ca. 3.800 per jaar</i>		Kostenbesparing door voorkomen onnodige zorghandelingen			Tijdsbesparing door implementatie digitale zelftriage HAP's		
Effect van de usecase	30 minuten bespaarde tijd per overdracht van/naar GGZ		Bericht #13: 30 seconden tijdsbesparing per uitwisseling		75 euro besparing per voorkomen onnodige zorghandeling, als gevolg van: • Effecten VVT en GGZ • Implementatie berichtnummers 7, 11, 13, 14			Jaarlijks 205.200 HAP-tel. gesprekken te vervangen door digitale zelftriage. Gemiddelde gespreksduur 6,97 minuten.		
	30 minuten bespaarde tijd per overdracht van/naar VVT		Bericht #14: 90 seconden tijdsbesparing per uitwisseling							
Onderstaande inclusiepercentages gelden voor alle doelgroepen en effecten (NB: volgorde van implementatie staat nog niet definitief vast)										
Inclusie					VVT/GGZ		Berichtnummer s			
2024	0%		0%		0%		0%		0%	
2025	0%		6,25%		0%		6,25%		6,25%	
2026	10%		25%		10%		25%		12,5%	
Zorgkosten (in EUR 1000) of FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE	Z	FTE
Impact 2024	0	x	x	x	0	x	0	x	0	x
Impact 2025	0	x	17	x	0	x	89	x	45	x
Impact 2026	14	x	69	x	68	x	371	x	94	x
1										
2 Cum. impact t/m 2026	14	x	85	x	68	460	x	140	x	
3) Aanname is dat deze werkstroom van dit transtormatieplan over de jaren heen voor max. 25% zal bijdragen aan het behalen van totale potentiële effect, aangezien dit voortbouwt op lopende projecten										

Usecase 2.5 – Netwerkszorg viewer



Netwerkgviewer voor Dossier Inzage – Ambitie

Faciliteren van multidisciplinaire dossierinzage van inwoners in de regio voor lagere werkdruk en verbeterde zorguitkomsten.



Kernproblematiek

- Dubbel invoeren en opvragen van gegevens, extra controles door onvolledige informatie of het niet ontvangen van data zorgen voor een hoge administratielast.
- Zorgprofessionals behandelen inwoners minder passend door het ontbreken van volledige, juiste of meest recente informatie.
- De zorgkwaliteit daalt door het ontbreken van een gestructureerd overzicht, waardoor zorg niet gepland kan worden en de juiste vragen niet gesteld kunnen worden aan de inwoner.
- Dubbele en foutieve diagnoses ontstaan door het niet inzichtelijk hebben van cruciale informatie.

Link IZA-opgaven

- **Verminderen administratieve lasten om zorgprofessionals te ontlasten;** minder opzoeken, structureren en controleren van gegevens
- **Behouden van beschikbare zorgprofessionals;** door vergroten werkplezier en meer tijd besteding aan zorg
- **Verbeterde zorguitkomsten;** passende zorg op tijd kunnen leveren aan de inwoner.



Huidige situatie

Professionals hebben geen of beperkte toegang tot (medische) gegevens van inwoners bij dossierhouders in andere . Hierdoor kunnen zij de zorg voor inkomende inwoners niet plannen, de beste zorg niet op tijd leveren en geen gebruik maken van reeds genoteerde informatie. Zorgprofessionals verliezen ook tijd aan het opvragen van informatie bij andere zorgorganisaties en het structureren en controleren van de juistheid en volledigheid van de data.



Ambitie, eind 2026:

- Gebruikmakend van de standaardisatie in gegevensvastlegging met behulp van de zorginformatiebouwstenen in de bronsystemen, integreren we deze data tot overzichtelijke views en bundeling van informatie over de grenzen van een organisatie, sector of domein. Directe ontsluiting van data uit diverse bronsysteem geeft het actuele beeld van beschikbare(gezondheids-)informatie over een inwoner.
- We creëren een holistisch beeld van de inwoner met multidisciplinaire inzage, wat tijd bespaart voor een (zorg)professional en helpt bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Daarmee komt de inwoner centraal te staan voor het netwerk van zorg en welzijn in zijn/haar regio.
- Het integrale beeld van de inwoner bevat typisch bruikbare weergaven van informatie van de inwoner, zoals bijvoorbeeld de basis gegevens zoals NAW- en contactgegevens, medische patiënt samenvatting met o.a. allergieën, diagnoses, medicatie en onderzoeksgegevens, verpleegkundige (overdrachts)gegevens en behandelwensen, doelen en/of voorkeuren van een inwoner.



Doorontwikkeling, na 2026:

1. We includeren meer soorten data via het fundament en stellen deze beschikbaar via de netwerkgviewer.
2. We bevorderen regionale samenwerkingen door aanvullende (zorg)processen met digitale netwerkg functionaliteiten te bieden zoals chat en beeldbellen
3. We maken data ook inzichtelijk voor de inwoner, zodat deze meer regie ervaart over zijn regionale (zorg)paden.



Netwerkgorg viewer voor Dossier Inzage

De netwerkgorg viewer draagt bij aan het ontlasten en ontzorgen van professionals, door een effectievere toegang tot actuele (zorg-)informatie met een 360-graden beeld van de inwoner.

Digitale zorgtoepassingen voor netwerkgorg in de regio Midden-Nederland

De netwerkgorg viewer is de presentatie laag voor gebruikers (user interface), waarbij er gebruik wordt gemaakt van de gestandaardiseerde wijze van koppelingen (API's) en uitwisseling van gestandaardiseerde en gestructureerde gegevenssets op basis van zorginformatie bouwstenen (Zib's) en informatiestandaarden.

De voorbereiding op het beschikbaar kunnen stellen van deze gegevenssets en de transformatie om deze informatie op gestructureerde wijze te kunnen registreren aan de bron (EOD/XIS/ECD) vindt plaats als onderdeel van de Wegiz geprioriteerde gegevensdiensten en de andere usecases onder thema 2. Denk hierbij aan de afspraken die op de bovenste lagen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz, zoals beleids- en procesafspraken en de realisatie van de afspraken zoals vastgelegd in de informatiestandaarden. Deze zijn voorwaardelijk om de basis op orde te krijgen voor de digitale zorgtoepassingen ten gunste van netwerkgorg in de regio. Ze vormen de basis voor het beschikbaar stellen van data voor onder meer de (crisisdiensten) VG, VVT, GGZ en/of revalidatie.

Vanuit de samenwerking en regionale transmurale afspraken, zullen verschillende digitale zorgtoepassingen waaronder het dynamische, rol afhankelijke, integraal 360-graden beeld, actueel medicatieoverzicht en proactieve zorgplanning, ook wel bekend als advanced care planning ACP beschikbaar gesteld, ter ondersteuning van de zorginhoudelijke processen en usecases.



Netwerkgzorg viewer voor Dossier Inzage – Beschrijving

De netwerkgzorg viewer draagt bij aan het ontlasten en ontzorgen van professionals, door een effectievere toegang tot actuele (zorg-)informatie met een integraal 360-graden beeld van de inwoner.

ACTUEEL MEDICATIE OVERZICHT

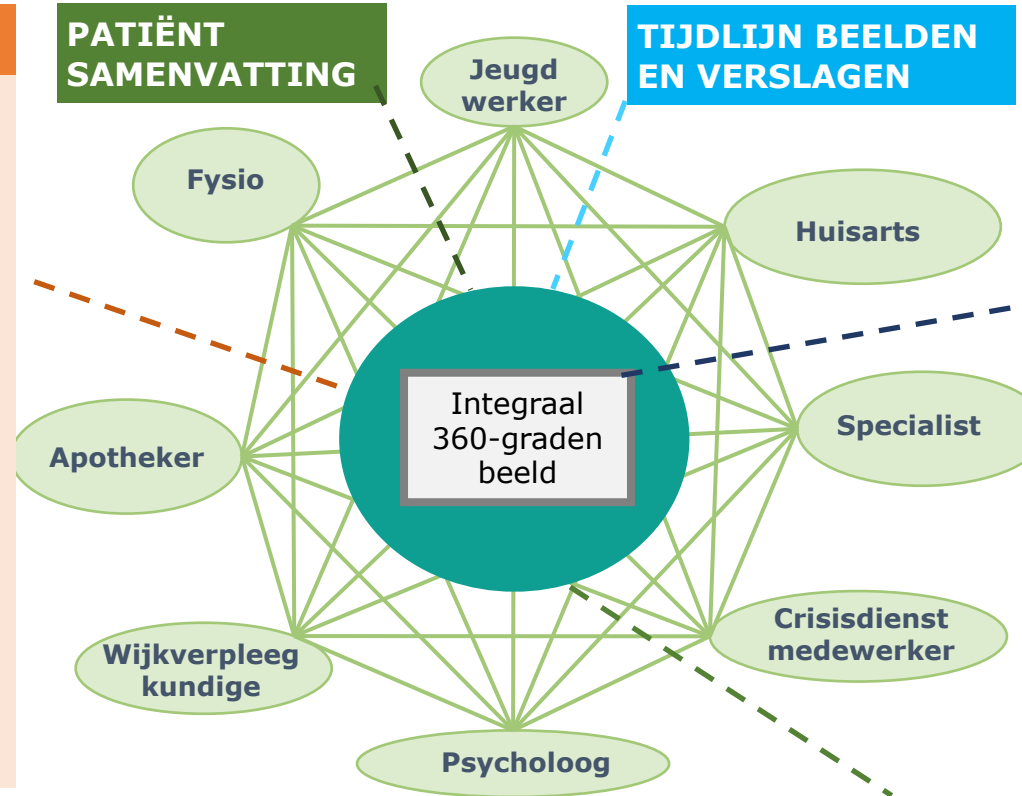
Doel: Op basis van een geconsolideerd overzicht van medicatie voorschriften aan een inwoner in de regio, een digitale zorgtoepassing om te komen tot een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) wat beschikbaar wordt gesteld via de netwerkgzorg viewer (360-graden beeld) voor dossierinzage. Een digitale omgeving waarin in het (zorg-) netwerk en rond de inwoner kan worden samengewerkt in het proces van medicatie verificatie en consolidatie o.b.v. regionale transmurale afspraken.

Resultaat: Minimaliseren van discrepanties met minimaal 50% waardoor medicatiefouten substantieel afnemen. Veel tijdsbesparing en lagere registratielast voor professionals in de hele medicatieketen. Actieve participatie van de inwoner in het medicatieproces.

Zorgtoepassing: Een Actueel Medicatie Overzicht in de context van een inwoner met weergave van lab resultaten en metingen beschikbaar op basis van de zorginformatie bouwstenen uit het Medicatieproces. In het overzicht kan medicatie worden toegevoegd, bewerkt en worden gecontroleerd op bijv. dosis, frequentie en status.

PATIËNT SAMENVATTING

TIJDLIJN BEELDEN EN VERSLAGEN



INTEGRAAL 360-GRADEN BEELD

Doel: Een actueel integraal 360-graden beeld met dossierinzage, met diverse weergaven (dashboards) beschikbaar voor professionals binnen zorg- en welzijnsaanbieders in de regio. Ter ondersteuning van een verbeterde samenwerking en effectievere toegang tot actuele informatie van inwoners. Vooral in acute (zorg)situaties en continuïteit van zorg.

Resultaat: Reductie in tijd voor het achterhalen van informatie en/of opnieuw uitvragen bij de inwoner. Minimaal 10% minder registratielast, minder fouten en het voorkomen van onnodige en ongewenste behandelingen.

Zorgtoepassing: Een compleet netwerkgzorg dossier samengesteld uit meerdere bronnen. Na registratie van patiënt in bronsysteem als EPD/XIS/ECD, actuele data in de regio over deze inwoner direct beschikbaar (op te halen) door een klik op de viewer knop. De viewer en daarmee het netwerkgzorg dossier, wordt in de context van de patiënt/inwoner geopend. De informatie geeft een 360-graden beeld en wordt getoond in logische datasets, zoals persoonsgegevens, medicatie, laboratorium resultaten en beleid.

PROACTIEVE ZORGPLANNING

Doel: De actuele behandelwensen en beleid van inwoners zijn op regionaal niveau beschikbaar voor betrokken professionals uit zorg- en welzijnsaanbieders in de regio. Er zijn regionale transmurale afspraken gemaakt over het registratieproces van proactieve zorgplanning. en eigenaarschap van de behandelwensen (data).

Resultaat: Doelmatigheid en efficiëntie en passende zorg in het netwerk van zorg en beschikbaarheid van actuele behandel wensen en beleid. Sneller kunnen handelen en tijdsbesparing voor zorgverleners door het ophalen van en zoeken naar behandelwensen.

Zorgtoepassing: Zorgverleners die over de domeinen heen kunnen samenwerken aan proactieve zorgplanning in een gezamenlijk overzicht op regionaal niveau in de netwerkgzorg viewer. Het biedt professionals de mogelijkheid om in het proces van proactieve zorgplanning een verslag te kunnen registreren via de netwerkgzorg viewer en inwonersdossier. De behandelwensen zijn direct beschikbaar voor (zorg-)netwerkpartners in de regio en inzichtelijk vanuit bronsystemen.



Netwerkgzorg viewer voor Dossier Inzage

De netwerkgzorg viewer en multidisciplinaire dossierinzage omvat technische componenten en functionele eisen.

Technische componenten integraal 360-graden beeld

Cruciale componenten die multidisciplinaire dossierinzage mogelijk maken.

Software tools

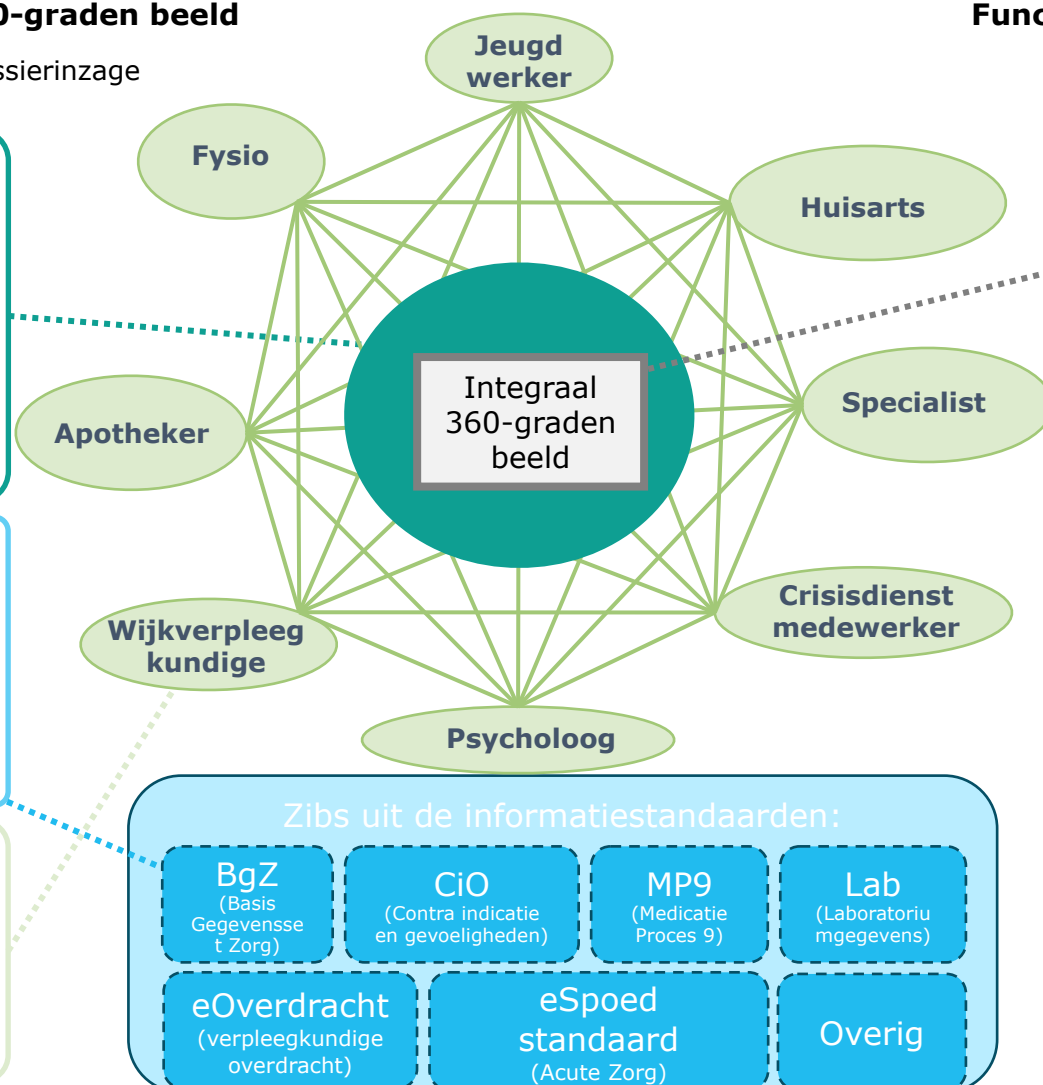
De netwerkgzorg viewer faciliteert dossierinzage. Het presenteert op basis van verschillende rollen (autorisaties) en toestemmingen, vanuit verschillende contexten rond de inwoner en werkt intuïtief voor de gebruiker. Gebaseerd op eisen en gebruikte applicaties in de regio, selecteren we de meest passende oplossing.

Informatie

Het integrale overzicht wordt gerealiseerd met behulp van gestandaardiseerde gegevens (Zibss/FHIR). Zorgorganisaties stellen deze zo veel mogelijk gestandaardiseerd beschikbaar, waar nodig met behulp van een koppelstuk (API) in het fundament.

Bronsystemen

Bronsystemen van genoemde (zorg) aanbieders / organisaties stellen data van de inwoner beschikbaar. Directe inlog (SSO) verschaft toegang tot de beschikbaar gestelde informatie uit de bron systemen.



Functionele eisen integraal 360-graden beeld

Een waardevol integraal 360-graden beeld heeft een aantal noodzakelijke weergaven.

Integraal 360-graden beeld

- De netwerkgzorg viewer met het integraal 360-graden beeld zal als optie verschijnen in bestaende(bron-) systemen van de gebruikers.
- Binnen de netwerkgzorg viewer is er de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende zorgtoepassingen.
- Verschillende weergaven (dashboards), en Digitale Zorgtoepassingen die ingebouwd worden zijn o.a.:
 - Patiënt samenvatting
 - Persoonsgegevens
 - Medische geschiedenis
 - (Actueel) Medicatie overzicht
 - Proactieve Zorgplanning
 - Documenten
- Meer zorgtoepassingen worden gerealiseerd aan de hand van voortschrijdend inzicht en worden uitvoerig getest met gebruikers.



Netwerkgzorg viewer voor Dossier Inzage – Impact

Het realiseren van multidisciplinaire dossierinzage heeft algemeen en per zorgtoepassing specifieke impact



Algemene Kwalitatieve impact¹

1

- Verbetering van kwaliteit van zorg door het hebben van de juiste, volledig en actuele informatie van de inwoner.
- Sneller passende zorg leveren.

2

- Minder herhaling van vragen van zorgverleners gedurende het zorgtraject
- Meer vertrouwen in zorg omdat reeds eerder verstrekte informatie bekend is bij zorgprofessional
- Soepelere overgang tussen zorgverleners voor inwoners

3

- Meer tijd voor zorgtaken door minder administratie en opzoeken en meer eenheid van taal.
- Beter inzicht in totaal plaatje inwoner, ook wat door andere zorgverleners is voorgeschreven, gedaan of is gewijzigd. Dit faciliteert betere samenwerking in de zorgketen tussen zorgverleners.
- Minder werkgerelateerde stress en meer plezier voor zorgprofessionals, aangezien er minder (telefonisch) contact nodig is om inzicht te krijgen in een inwoner. Zorgprofessionals hebben ook meer vertrouwen in de informatie die zij hebben/krijgen.

4

- Betere kwaliteit en continuïteit van zorg, met als gevolg dat een inwoner sneller de juiste zorg krijgt en minder onnodige zorg geleverd krijgt of bedden bezet houdt.
- Zorgprofessionals zijn per saldo minder tijd kwijt aan handelingen rond medicatie (voorschrijven, verstrekken, toedienen) omdat zij minder tijd kwijt zijn aan het verifiëren
- Minder zorghandelingen zoals ziekenhuisopnames of consulten bij huisartsen, instellingsartsen of de spoedeisende hulp door afname incidenten

Zorgtoepassing specifieke kwalitatieve impact



Integraal 360-graden beeld

- Meer passende zorg kunnen leveren door het hebben van een compleet beeld van de inwoner.
- Makkelijker samen kunnen werken met andere zorgprofessionals rond een inwoner.



Actueel medicatie overzicht

- Minder ongewenste interactie tussen medicijnen door het niet op de hoogte zijn van medicatie gebruik.
- Betere zorguitkomsten door het passend kunnen voorschrijven van medicatie of het aanpassen van het huidige medicatie gebruik.
- Minder navragen bij de inwoner.



Proactieve zorgplanning

- Meer regie en autonomie bij de inwoner over haar/zijn zorgproces.
- Betere communicatie tussen de inwoner en de zorgprofessional over haar/zijn wensen.
- Minder stress en onzekerheid bij inwoners en hun naasten door het vastleggen van toekomstige medische interventies.



0.0 Fundament Digitalisering & Gegevensuitwisseling

1.1	Thema	2.1	Thema
Digitaal en Gegevensuitwisseling met focus op patiënten, en interdisciplinaire samenwerking bij ondersteuning van netwerkzorg	Dossier: Inzage en Digitale Overdracht van (Aankomst) Zorg	2.1 Basis gegevenswet Zorg Medisch Specialistische Zorg Medische wet de Wet gegevenswetgeving van 2012	
1.1 Medisch wetgeving		2.1 Basis gegevenswet Zorg Medisch Specialistische Zorg Medische wet de Wet gegevenswetgeving van 2012	
1.2 Digitalisering wetgeving		2.2 Medische Overdracht Medische wet de Wet gegevenswetgeving van 2012	
1.3 Toezicht wetgeving		2.3 Verpleegkundige Overdracht (Verpleegkundig) Medische wet de Wet gegevenswetgeving van 2012	
1.4 Andere wetgeving		2.4 Andere wetgeving	
Uitvoeren: reclasseren, verspreiden of integreren gegevens verspreiden			
0.0 Fundament Digitalisering & Gegevensuitwisseling			
Conceptueel ontwerp: Inzage & Digitale Overdracht van (Aankomst) Zorg op de juiste plek in de zorg			



Fundament – Ambitie

Het fundament is vereist om databeschikbaarheid te realiseren in de verandering naar netwerkzorg.



Rationale achter het fundament

De kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk door vergrijzing, hoge administratieve lasten en personeelstekort. Zorgprofessionals hebben geen volledig beeld van de inwoner, wat de zorguitkomsten en hun effectieve tijdsbesteding negatief beïnvloedt. Ook hebben inwoners weinig regie en inzicht in hun eigen situatie. Dit moet veranderen.

Databeschikbaarheid en netwerkzorg zijn cruciaal voor deze benodigde transformatie. Alle betrokken partijen in het zorgnetwerk van de inwoner moeten goed ondersteund worden met relevante informatie. Zorgprofessionals kunnen betere zorg leveren als zij een holistisch beeld van de inwoner hebben, met de juiste informatie op het juiste moment. Zo krijgt ook de inwoner meer controle krijgt over zijn zorgproces.

Een holistisch beeld van de inwoner is nodig voor het leveren van passende zorg. Uitgangspunt hierbij is de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment. Hiervoor is een platform vereist, waarin de relevante gegevens van een inwoner uit verschillende bronnen veilig beschikbaar worden gesteld aan de zorgprofessional en de inwoner.

Dit data platform ondersteunt de geprioriteerde use cases uit dit transformatieplan, en moet netwerkzorg in brede zin ondersteunen. Het dient ook bruikbaar te zijn voor nieuwe innovaties (zoals AI, DSS) en onderzoek (secundair gebruik).

Met het platform wordt de professional beter ondersteund met relevante integrale informatie over de inwoner, waardoor de werkdruk verlaagd kan worden, de kwaliteit van de zorg verhoogd wordt en MDO-overleggen beter ondersteund worden. Inwoners krijgen beter inzicht in hun zorggegevens en kunnen meer regie nemen over hun eigen zorgproces.

Met het fundament versnelt de regio realisatie van de volgende effecten van netwerkzorg



Inwoner

- Krijgt zorg die beter passend is bij het totaal plaatje
- Hoeft minder lang (af) te wachten op de juiste zorg
- Hoeft minder vaak informatie te herhalen
- Krijgt meer regie over het eigen zorgproces
- Ervaart betere zorguitkomsten



Zorgprofessional

- Minder administratieve last door overtypen en nabellen
- Betere samenwerking met collega zorgprofessionals
- Kan meer focussen op leveren van zorg
- Minder wachten en nabellen voor juiste informatie
- Meer structuur in werkwijze
- Vergroot werkplezier



Regio

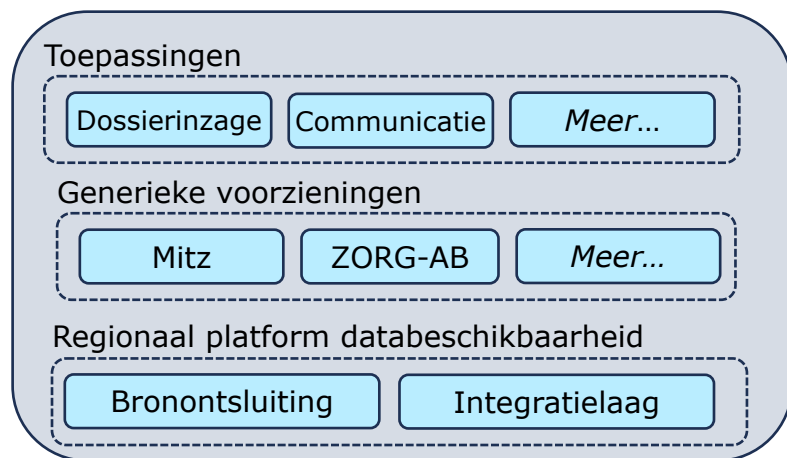
- Meer regie op gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid
- Zorg blijft toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar
- Verregaande en betere samenwerking
- Effectief gebruik van innovaties
- Efficiëntere coördinatie van zorg



Opstartstructuur fundament

De 3 onderdelen van het fundament zijn cruciaal voor gestructureerde databeschikbaarheid en een holistisch beeld van de inwoner

Het **fundament** voor digitalisering en gegevensuitwisseling bevat de techniek en afsprakenstelsels die nodig zijn voor goed georganiseerde data beschikbaarheid en dossier inzage, beide rand voorwaardelijk is voor netwerkzorg.



Het fundament is binnen deze opstartfase opgedeeld in drie verschillende onderdelen, die op verschillende lagen in de doel architectuur een rol spelen.



Onderdelen van het fundament

- 1. Regionaal Platform voor databeschikbaarheid:** Dit zorgt voor de infrastructuur waar gegevens doorheen stromen, wat essentieel is voor samenwerking en efficiëntie.
- 2. Toepassingen:** Deze stellen gebruikers in staat om effectief met de gegevens te werken, wat de toegankelijkheid en bruikbaarheid vergroot.
- 3. Generieke Functies:** Deze omvatten standaarden en afspraken die ervoor zorgen dat gegevens vindbaar en toegankelijk zijn voor verschillende toepassingsgebieden, wat de interoperabiliteit bevordert.



1. Platform voor databeschikbaarheid

Het platform voor databeschikbaarheid integreert gegevens van inwoners uit verschillende bronnen en stelt deze beschikbaar aan zorgaanbieders en inwoners in de regio Midden-Nederland. Het platform faciliteert een holistisch beeld van de inwoner en bevordert samenwerking in de regio. De onderdelen en functionaliteiten worden ingericht volgens bestaande initiatieven, landelijke standaarden en afsprakenstelsels. Daarnaast worden regionale uitgangspunten gehanteerd, zodat het platform zowel voor als door zorgprofessionals en inwoners van de regio is.

Bronontsluiting

Het platform biedt meerdere methoden voor bronaansluiting, die per bronsysteem passend worden gemaakt.

Inegratielaag

De integratielaag verbindt verschillende bronsystemen en toepassingen voor organisatie overstijgende databeschikbaarheid.



2. Toepassingen

Gebruikte toepassingen zijn de viewer voor dossierinzage voor de zorgprofessional (*usecase 2.5*) en de viewer voor communicatie met de inwoner (*use case 1.3*).



3. Generieke voorzieningen

Voor de generieke functies zal o.a. met MitZ, Twiin en ZORG-AB doorlopen worden.



Fundament – Organisatie en inrichting

Een op te richten team binnen RSO Trijn zal het platform databeschikbaarheid gestructureerd vormgeven, opzetten en uitrollen



Organisatie en inrichting platform databeschikbaarheid

Een nieuw op te richten domein overstijgend en multidisciplinair team in de regio zal de regionale databeschikbaarheid via het platform realiseren. Dit team zorgt ervoor dat:

- De inrichting zoveel mogelijk gebruikmaakt van bestaande initiatieven zoals CumuluZ, Zorgviewer en Digizorg, en aansluit op regionale en landelijke inrichtingen en afsprakenstelsels. Ook zorgen zij voor een goede samenwerking met deze partijen.
- De realisatie in goede communicatie plaatsvindt met de deelnemende partijen in de regio, met de juiste en volledige uitgangspunten en volgens de meest logische ordening.
- De roadmap aansluit op de doelarchitectuur, mee verandert met veranderende landelijke en Europese wet- en regelgeving, en de meeste waarde voor de regio biedt.

Bestaande initiatieven

De regio wil bestaande concepten en middelen zoveel mogelijk (her)gebruiken. Bijvoorbeeld;

- CumuluZ componenten.
- Zorgviewer.
- Lopende trajecten voor generieke functies.
- Zorgnetwerkomgeving HINQ.
- Data Delen Midden-Nederland (MDO platform).
- Digizorg.

Wet- en regelgeving

De regio neemt wetten en richtlijnen vanuit de overheid mee bij de inrichting en de roadmap van het platform, onder andere;

- Gebruik van zibs.
- Richtlijnen VWS.
- Wegiz gegevensstandaarden.
- AVG (privacy).
- EHDS (European Health Data Space)

Afsprakenstelsels

De regio hanteert afsprakenstelsels om data op een veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Deze sets van afspraken bepalen de eisen voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid

Het fundament maakt gebruik van bestaande afsprakenstelsels zoals AORTA-LSP, NUTS, MedMij en Twiin.

Interoperabiliteit

De regio geeft vorm aan de transformatie aan de hand van het Nictiz 5-lagen model en randvoorwaarden.

- Samenwerking organisaties
- Samenwerking in zorgprocessen
- Vastleggen en delen van informatie
- Gebruik van zorginformatiesystemen
- Technische infrastructuur



Uitgangspunten en leidende principes

Het fundament wordt ingericht en gerealiseerd gebaseerd op regionale leidende principes en uitgangspunten.

De visie van de Trijn voor de regio Midden Nederland is dat alle partijen betrokken bij de gezondheid, zorg en het welzijn van inwoners digitaal en datagedreven met elkaar samenwerken. We leveren met elkaar netwerkzorg naar behoefte in steeds wisselende samenstellingen. Daarvoor is het nodig dat de juiste informatie beschikbaar en inzichtelijk is en dat men naar nut en noodzaak datacomponenten kan overhalen naar de eigen systemen. We moeten de huidige situatie waarin zorgverleners vaak cruciale informatie missen voorkomen. Daarvoor zullen we in de regio met elkaar een generiek fundament, een regionaal dataplatform realiseren en waar mogelijk gezamenlijke applicaties daarop aansluiten.

Leidende principes

- Gezamenlijke applicaties sluiten aan op het regionale dataplatform en bieden meerwaarde voor inwoners en/of zorgverleners
- We delen relevante informatie en maken deze beschikbaar voor alle betrokkenen in het zorgnetwerk van een inwoner en voor de inwoner zelf, mits er toestemming van de inwoner is.
- We sluiten aan op landelijke ontwikkelingen: generiek als uitgangspunt en specifiek waar strikt noodzakelijk
- Oplossingen zijn veilig
- Oplossingen zijn duurzaam en toekomstbestendig (flexibel en schaalbaar)
- Oplossingen zijn beheersbaar en gestandaardiseerd



Belangrijkste uitgangspunten

- De inwoner heeft regie, kan zelf een dossier bijhouden en informatie beschikbaar stellen aan zijn zorgverleners.
- Zorgprofessionals worden betrokken in vernieuwingstrajecten om te borgen dat oplossingen bijdragen aan het verbeteren van werkplezier en het verlagen van werkdruk.
- We volgen digitale innovaties en maken gebruik van AI- toepassingen (kunstmatige intelligentie) waar zinvol en betrouwbaar.
- We zetten in op federatieve data beschikbaarheid waar dit mogelijk is (decentrale dataopslag met geautoriseerde toegang).
- We maken gebruik van open standaarden en landelijke richtlijnen en platformen (FHIR, OpenEHR, CumuluZ, EHDS, Nuts, MitZ)
- Data is beschikbaar voor secundair gebruik (FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar))
- Organisaties moeten eenvoudig kunnen aanhaken.
- Elke deelnemende instelling zal een deel autonomie inleveren ten behoeve van de regionale beslissingen.



Regionale route verbetering databeschikbaarheid

Databeschikbaarheid wordt eerst verbeterd met een tijdelijke oplossing en gefaseerd overgezet naar het regionaal platform databeschikbaarheid

Brede beschikbaarheid van medische- en gezondheidsgegevens over de grenzen van de instellingen heen is essentieel om zorg effectief en efficiënt te kunnen leveren in het netwerk rondom de inwoner. Die brede beschikbaarheid geeft mogelijkheden om de zorg te transformeren, maar is ook belangrijk voor de sociale basis en voor secundair gebruik (onderzoek).

De beschikbaarheid van gegevens wordt op dit moment voor een belangrijk deel vormgegeven door het uitwisselen van gegevens. Dit betreft altijd een volledige set aan gegevens en een momentopname tussen twee partijen. Landelijk vindt een beweging plaats van gegevensuitwisseling naar actuele databeschikbaarheid, waarbij de data in de bronnen blijft en geïntegreerd wordt aangeboden in een toepassing (b.v. een viewer). Deze mogelijkheden komen binnen handbereik door initiatieven zoals Zorgviewer (voor zorgverleners) en Digizorg (voor inwoners). Dit zijn toepassingen die aangesloten zijn op een data- en integratielaag die zijn gestoeld op de CumuluZ-architectuur.

Het Regionaal Platform Databeschikbaarheid wordt een 'CumuluZ-hub' dat onderdeel wordt van het LDN (Landelijk Dekkend Netwerk). De realisatie van dit platform moet nog starten en zal naar verwachting de komende twee jaar relatief weinig waarde kunnen toevoegen aan de use case 'Multidisciplinaire inzage' of de opgave uit Wegiz. Daarom is er gekozen om een tijdelijk platform voor databeschikbaarheid te realiseren, gebaseerd op voorzieningen die al in de regio worden gebruikt.

De voorzieningen die al in gebruik zijn in de regio zijn het ZNO van HinQ (BabyConnect / Praktijkbeproeving) of Vitaly (Data Delen Midden Nederland ter ondersteuning van oncologische MDO's). Dit wordt in dit plan de 'Tijdelijke oplossing' genoemd.

De tijdelijke oplossing wordt op korte termijn gerealiseerd om op de use case 'Multidisciplinaire inzage' te ondersteunen (zie ook slide xx). Parallel wordt het regionale platform databeschikbaarheid ontwikkeld. Op het moment dat het regionale platform capabilities van de tijdelijke oplossing kan overnemen, dan worden deze capabilities overgezet. Zo wordt de tijdelijke oplossing gefaseerd afgebouwd.



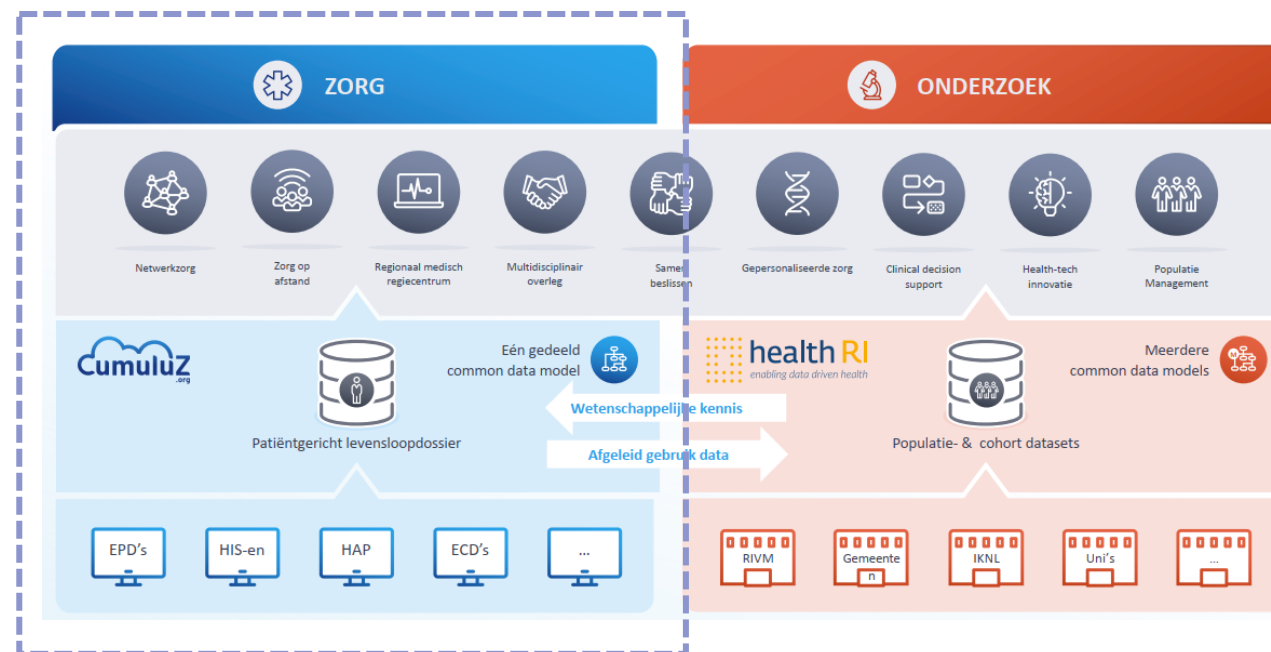
Regionaal Platform Databeschikbaarheid (RPD) en Health Data Space Utrecht (HDSU)

Waar het kan zal de infrastructurele onderlaag in de gemeenschappelijkheid met de HDSU ingericht worden

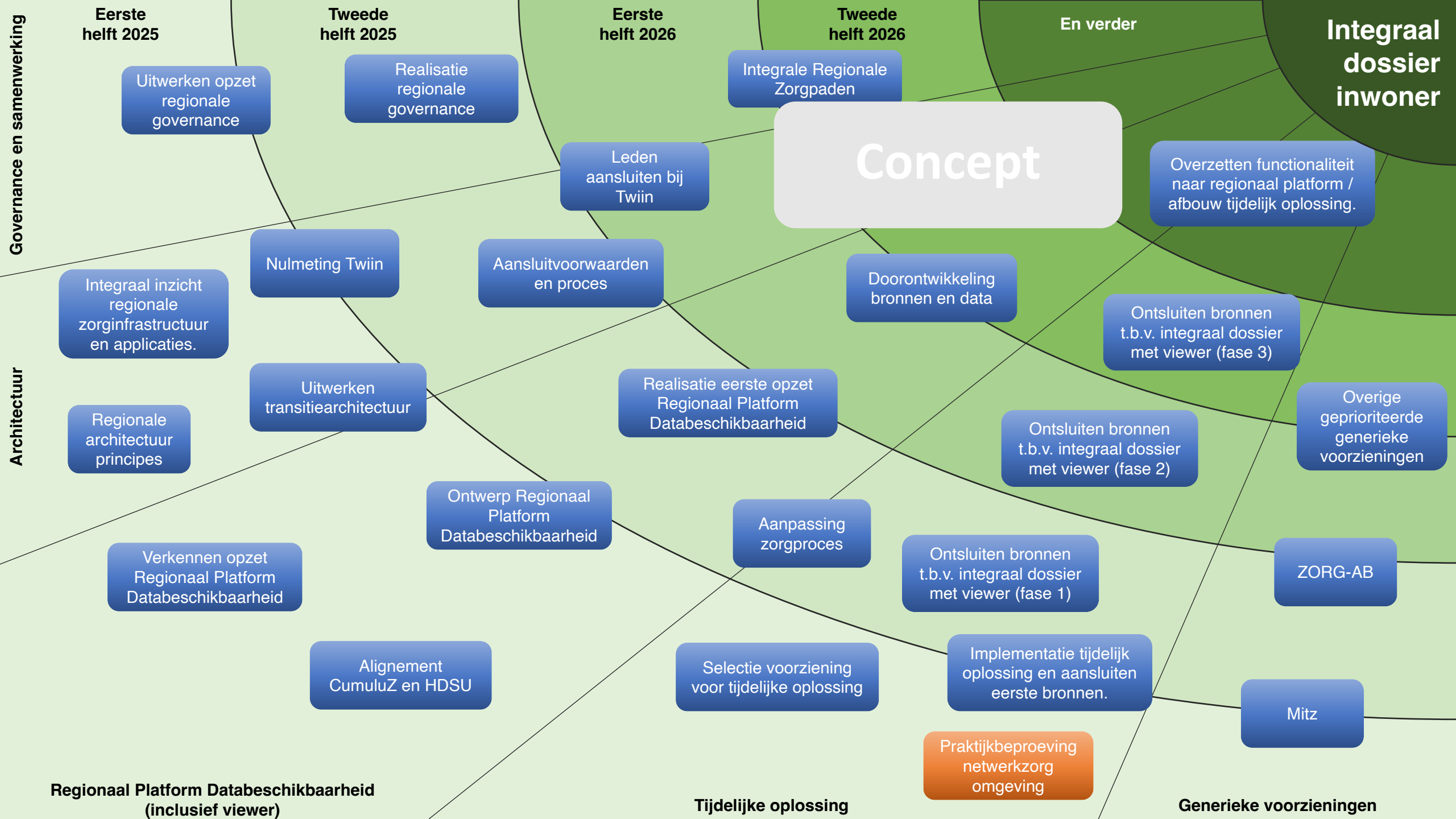
Regionaal platform VS. HDSU

In de regio Utrecht is het UMCU gestart met de ontwikkeling van de HDSU (Health Dataspace Utrecht). Dit wordt de regionale implementatie van HealthRI (Health Research Infrastructure), volgend uit de EHDS-verordening. Het doel is om onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en innovators onder vergunning toegang te bieden tot (gecombineerde of gekoppelde) gezondheidsdata voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming en -monitoring.

Het Regionaal Platform Databeschikbaarheid én HDSU dienen allebei data beschikbaar te maken. Voor het RPD gaat het om data van één inwoner; voor de HDSU gaat het om data van een selectie van inwoners/patiënten. Het doel is verschillend, maar in beide gevallen gaat het om het beschikbaar maken van data. Idealiter maken beide programma's gebruik van dezelfde basisinfrastructuur. Tijdens de ontwikkeling van het Regionale Platform Databeschikbaarheid en de HDSU wordt gekeken hoe gezamenlijk op te trekken.

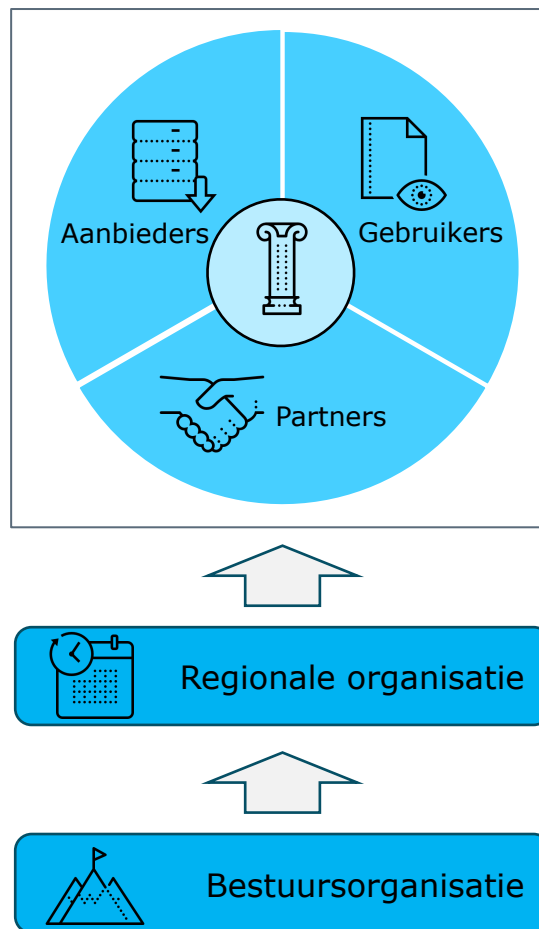


Scope transformatieaanvraag



Governance voor realisatie en sturing fundament

Governance van het fundament bestaat uit stakeholders, een operationele en een strategische organisatie.



Het fundament voor de regionale databeschikbaarheid bestaat uit het regionale platform voor databeschikbaarheid, toepassingen (bijvoorbeeld viewers voor zorgprofessionals of inwoners) en generieke voorzieningen. De governance omvat de organisatie om het fundament te realiseren, te onderhouden en door te ontwikkelen én de besturing van deze organisatie.

Het fundament kent de volgende stakeholders*:

- **Aanbieders van data:** Organisaties of personen die relevante datasets beschikbaar stellen aan het regionale platform voor databeschikbaarheid.
- **Gebruikers van data:** Organisatie of persoon die de beschikbare data uit het platform raadpleegt voor het kunnen leveren van zorg, besluitvorming, analyse, onderzoek, etc.
- **Partners:** Leveranciers en andere (zorg)organisaties waarmee de regio samenwerkt om het fundament te onderhouden, door te ontwikkelen en diensten uit te breiden.

De regio richt de volgende organisaties en gremia in voor realisatie, sturing, beheer en doorontwikkeling van het fundament:

- **Regionale organisatie Fundament**

De regionale organisatie is verantwoordelijk voor de realisatie, het dagelijkse beheer en doorontwikkeling van het fundament. Dit houdt o.a. in dat ervoor wordt gezorgd dat de technologie naar behoren functioneert en dat gebruikers op de juiste manier worden ondersteund. Deze organisatie heeft de regie over het fundament en bewaakt de efficiëntie en betrouwbaarheid ervan.

- **Bestuur regionale organisatie Fundament**

Deze organisatie stuurt en stelt kaders op strategisch niveau en werkt samen met de architectuur raad. Hier worden onder andere het beleid, strategie en prioritering van het portfolio vastgesteld.

De regionale organisaties voor het fundament worden ondersteund door de inmiddels opgerichte regionale architectuurraad.



Taken en verantwoordelijkheden rond het fundament

Organisaties en stakeholders hebben taken en verantwoordelijkheden rondom het realiseren, gebruiken en doorontwikkelen van het fundament

Regionale operationele organisatie fundament

- Planning en uitvoering van visie, beleid fundament en bijbehorende doelarchitectuur;
- Overzien van generieke voorzieningen;
- Afstemming tussen aanbieders, gebruikers en partners;
- Afstemming regionale en landelijke initiatieven zoals het LDN, CumuluZ, Health-RI, Wegiz en HDSU;
- Projectmanagement rondom de realisatie van het fundament;
- Ontwikkeling diensten t.b.v. (geprioriteerde) use cases;
- Datamanagement;
- Aansluiten nieuwe en beheren huidige deelnemers;
- Compliance en Security;
- Leveranciersmanagement.



Bestuur regionale organisatie fundament

- Vaststellen en uitdragen visie en missie;
- Vaststellen beleid;
- Prioritering portfolio;
- Beleid en toelating nieuwe deelnemers op het regionale platform voor data-beschikbaarheid;
- Afstemming architectuurraad;
- Juridische kennis.

Fundament

Regionaal platform databeschikbaarheid

Bronontsluiting

Integratielaag

Toepassingen

Viewer

Onderzoek

Meer...

Generieke voorzieningen

Mitz

ZORG-AB

Meer...

Aanbieders

- Beschikbaar stellen relevante datasets aan het regionale platform;
- Aansluiting op het data platform;
- Datamanagement te verzenden data;
- Procesverandering voor datakwaliteit.

Gebruikers

- Gebruik van relevante gegevens uit het regionale platform voor o.a. het leveren passende zorg of doen van onderzoek.
- Input leveren doorontwikkeling van diensten.

Partners

- Leveren diensten voor het fundament;
- Samenwerking en ondersteuning;
- Doorontwikkeling waar wettelijk vereist.

* Aanbieders en gebruikers van data zijn niet alleen de zorginstellingen, maar ook inwoners, de gemeente, het sociale domein, preventie, paramedici, etc.

Kosten realiseren en beheren fundament

Getallen zijn indicatief en worden nog gevalideerd!!

Inzet	Uren IZA-periode	Uurtarief	Kosten	Opmerking
Regionale architect	3.200	€ 120	€ 384.000	Coördinatie en inhoudelijke ondersteuning.
Projectleiders	6.400	€ 120	€ 768.000	
Business analist	3.200	€ 120	€ 384.000	
Engineers	16.000	€ 120	€ 1.920.000	Afhankelijk van geselecteerde oplossing.
Inzet interne architecten leden	3.200	€ 100	€ 320.000	
Interne inzet leden rond Twiin-vraagstuk	3.200	€ 100	€ 320.000	
Interne inzet leden rond platform voor databeschikbaarheid	16.000	€ 100	€ 1.600.000	
Interne inzet leden rond tijdelijke oplossing	6.720	€ 100	€ 672.000	
Inzet externe dienstverlener tijdelijke oplossing			€ 300.000	150K per jaar.
Totaal			€ 6.000.000	
Onderdeel	Column1	Kosten per jaar		
Infra en netwerk		€ 500.000		
Integratie o.b.v. Fabric		€		
Applicaties en licenties				met meenemen in aanvraag. Structurele kosten.
Tijdelijke oplossing (HINQ / Vitaly)			€ 500.000	
Totaal			€ 1.000.000	

Aandachtspunten:

- Wel/niet BTW meenemen? Nu zonder BTW.
- Intern tarief (nu 100 genomen).
- Kunnen de leden de interne inzet waarmaken / intern compenseren.
- Kunnen we een betere inschatting maken voor tijdelijk oplossing (BabyConnect / DDMN).



Overkoepelende business case en investeringsaanvraag



Toelichting op het tot standkomen van de businesscase

In 6 stappen komen tot een maatschappelijke businesscase met draagvlak bij alle partijen

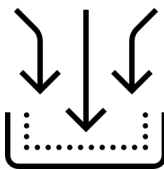
1. Bepalen uitgangspunten



Komen tot uitgangspunten op welke manier de analyse opgezet.

Eén keer opstellen voor gehele analyse

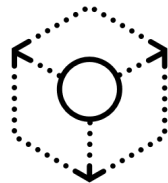
2. In kaart brengen input parameters



Komen tot uniforme set aan basisgetallen, die ten grondslag liggen aan de impactanalyse en investeringsaanvraag.

Waar mogelijk dezelfde input parameters hanteren voor alle use cases en gevraagde investeringen

3. Onderbouwen van verwachte effecten



Per use case aannames maken wat de verwachte beoogde effecten zijn. Deze dienen met experts en bij stakeholders gevalideerd te worden.

Per use case opstellen. Op basis van pilots, literatuur, referenties, 'best guess'. Validatie bij specialisten, verpleegkundigen, en overige experts

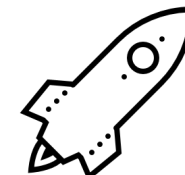
4. In kaart brengen benodigde investeringen & structurele kosten



Bepalen welke investeringen, gedurende de scope van het transformatieplan nodig zijn om de 'transformatie' te kunnen realiseren.

Deels op use case niveau te bepalen, maar ook overkoepelend

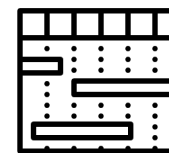
5. Bepalen ambitie en impact op regionale opgave



Per use case in gezamenlijkheid bepalen wat het ambitieniveau is.

Per use case en overkoepelend bepalen en consolideren voor het hele transformatieplan

6. Opstellen mijlpalenplanning



Koppelen van benodigde investering aan de mijlpalenplanning; wanneer ontvang je welk bedrag van de zorgverzekeraar?

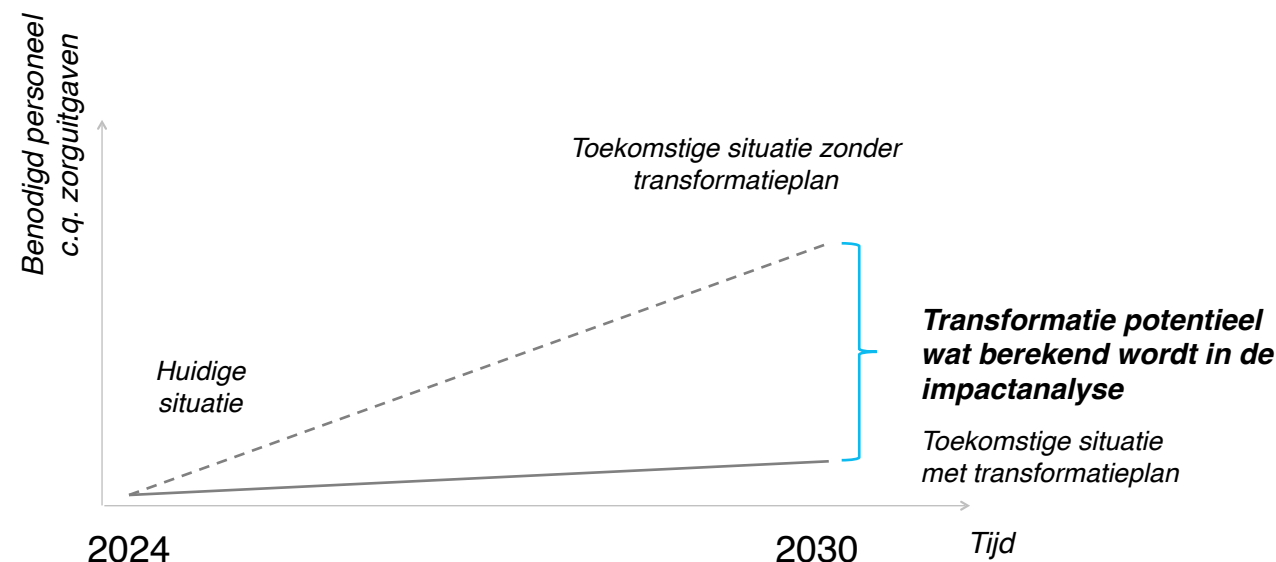
Stappen 3 t/m 6 – dienen iteratief/ parallel uitgewerkt te worden

Investeringen hangen bijvoorbeeld af van de planning, en de ambitie dient te zijn afgestemd op verwachte oplevering van functionaliteiten en het adoptievermogen.

Uitgangspunten businesscase

Vier uitgangspunten onderliggend aan de businesscase uit- en toegelicht ¹

- 1 Het potentieel van dit transformatieplan wordt uitgedrukt in **tijds winst (in fte)** en **impact op zorguitgaven (€'s)**. Hierbij wordt de toekomstige situatie met transformatieplan afgezet tegen de toekomstige situatie zonder transformatieplan.
- 2 Voor de doorrekening van de impact gaan we uit van een **potentieel- en investeringsberekening**. Hierbij hanteren we de **ceteris paribus** voorwaarde: 'alle overige factoren blijven gelijk'. We zetten de **toekomstige situatie met** en **zonder transformatieplan** tegen elkaar af, gegeven de stijgende zorgvraag, waarbij we personele tekorten en andere limiterende factoren buiten beschouwing laten. Dit om de 'ontoegankelijkheid van zorg' en gezondheidsverlies niet te hoeven berekenen. Het betreft dus een **fictieve doorrekening** om zoveel mogelijk '**appels met appels**' te kunnen **vergelijken**.
- 3 De tijds winst betreft **geen fte-besparing**, maar gaat om een fictieve afbuiging om met **hetzelfde personeel meer** van de **zorgvraag** op te kunnen vangen – oftewel met hetzelfde aantal zorgverleners meer patiënten kunnen zien.
- 4 De hierboven beschreven **tijds winst** (in fte) is een **uitkomst** van het verwachte effect van de use cases die onderdeel uitmaken van dit transformatieplan. Om deze te **effectueren** is **niet alleen** een **digitale** en **procesverandering**, maar ook een **cultuurverandering** nodig. Hier wordt rekening mee gehouden in het plan qua benodigde inzet en investering

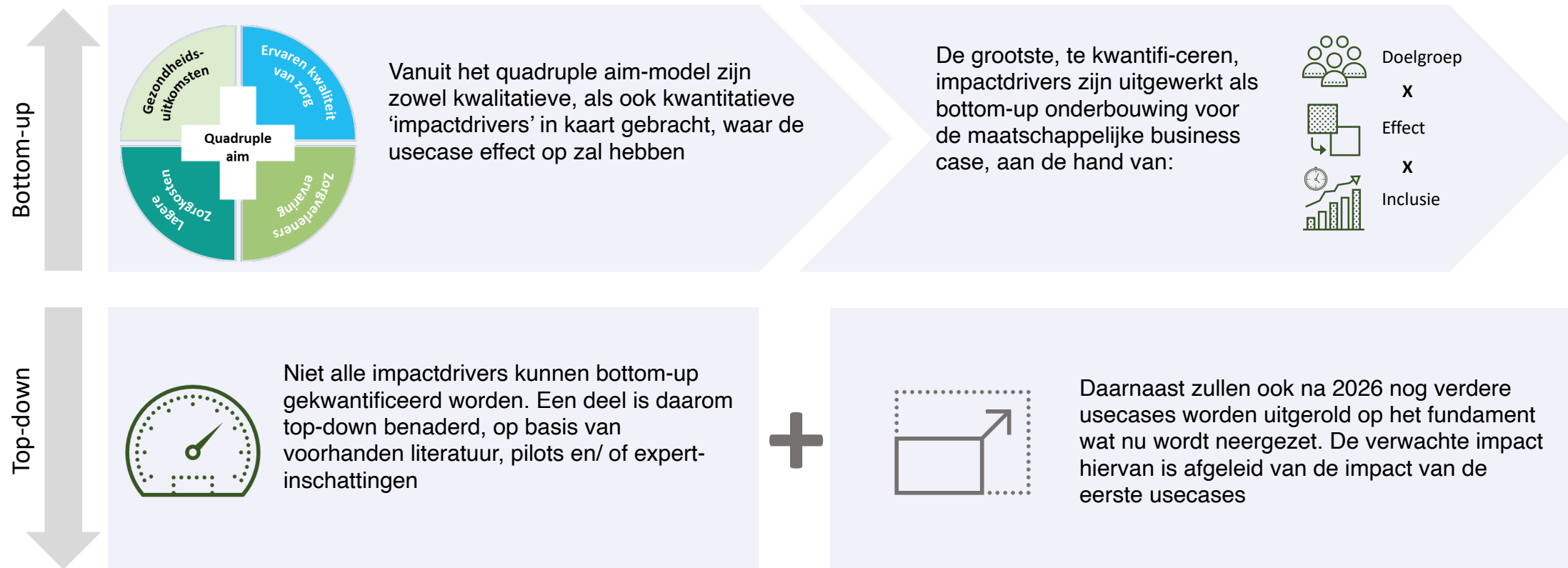


1) Een overzicht van alle gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de businesscase is terug te vinden in de bijlage



Bepalen van de impact

De verwachte impact van dit transformatieplan wordt 'bottom-up' en 'top-down' benaderd

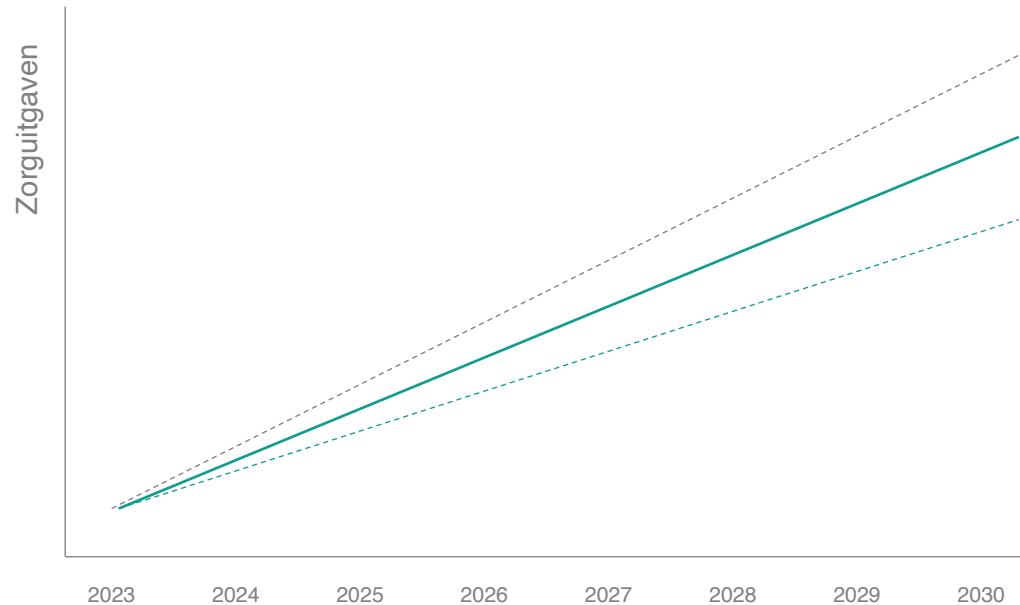




Verwachte impact op zorgkosten

Kwantitatieve impactdrivers zijn bottom-up berekend, kwalitatieve impactdrivers zijn top-down benaderd

Met realisatie van dit transformatieplan buigen de verwachte jaarlijkse zorguitgaven af



- De zorgkosten (Zvw) in de regio Midden-Nederland zijn ca. € XX miljard in 2023 en stijgen jaarlijks met gem. X,X% tot ca. € XX miljard in 2030 ^{1,2}
- Met realisatie van de usecases uit dit transformatieplan komt vanaf 202X meer ruimte voor de zorg vrij, d.w.z. er kan meer zorg geleverd worden met dezelfde (medische) professionals
- Bottom-up is gekwantificeerd dat in 2026 met de usecases in dit plan ca. X,X% de van de jaarlijkse zorguitgaven wordt omgebogen. Top-down is beredeneerd dat additioneel minimaal X,X% additioneel kan worden omgebogen. Dit staat gelijk aan ca. € X,X miljoen euro per jaar wat aan zorgruimte gecreëerd wordt ten opzichte van de situatie zonder dit transformatieplan
- Daarnaast wordt met dit transformatieplan een fundament gelegd wat als vliegwiel dient voor de digitalisering in de regio. Ook na 2026 zullen aanvullende usecases (zoals X, Y, Z) uitgerold worden, wat richting 2030 naar verwachting nog eens € X à Y miljoen per jaar aan zorgruimte creëert per jaar.

1) Bronnen: RIVM (% stijging zorguitgaven), Zorgcijfersdatabank (zorguitgaven)

2) De stijging van zorgkosten is benaderd door het RIVM en neemt hierin de volumegroei o.b.v. demografie, prevalentie en incidentie van ziekten etc. mee. Prijsontwikkelingen zijn hierin niet meegenomen (nominale groei)



Samenvatting

Achtergrond en
aanleiding

Visie en ambitie

Veranderopgaven en
verwachte impact

Fundament
digitalisering

Thema 1:
Digitale (zorg)
communicatie

Thema 2: Dossier-
inzage en digitale
overdracht

**Overkoepelende
businesscase**

Governance en
programma-structuur

Implementatie
planning en aanpak

Randvoorwaar-den
voor succes

Bijlagen

Verwachte impact op zorgpersoneel

[Placeholder] -> zelfde soort slide als voorgaande, maar dan met focus op personeel

Overzicht kwantitatieve impactanalyse

	Impact op zorgpersoneel in 2029 (in fte)							Impact op zorgkosten jaarlijks vanaf 2029 (x € 1.000)						
	MSZ	VVT	Huis-artsen	Apotheek	GGZ	Overige sectoren	Totaal	MSZ	VVT	Huis-artsen	Apotheek	GGZ	Overige sectoren	Totaal
Digitale (zorg) communicatie														
Medische overdracht														
Medicatie-overdracht														
Verpleegkundige overdracht														
Overdracht Acute zorg														
Netwerkgzorg viewer														
Totaal														

Overzicht kosten t/m 2029

(x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Cumulatief
Frictie kosten	€ XXX	€ XXX	€ XXX				€ X.XXX
Personeel	€ XXX	€ XXX	€ XXX				€ X.XXX
Materieel	€ XXX	€ XXX	€ XXX				€ X.XXX
Directe structurele kosten	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	
Personeel ²	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	
Materieel ³	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	
Totaal	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	€ XXX	



Impact transformatieplan in relatie tot benodigde investering

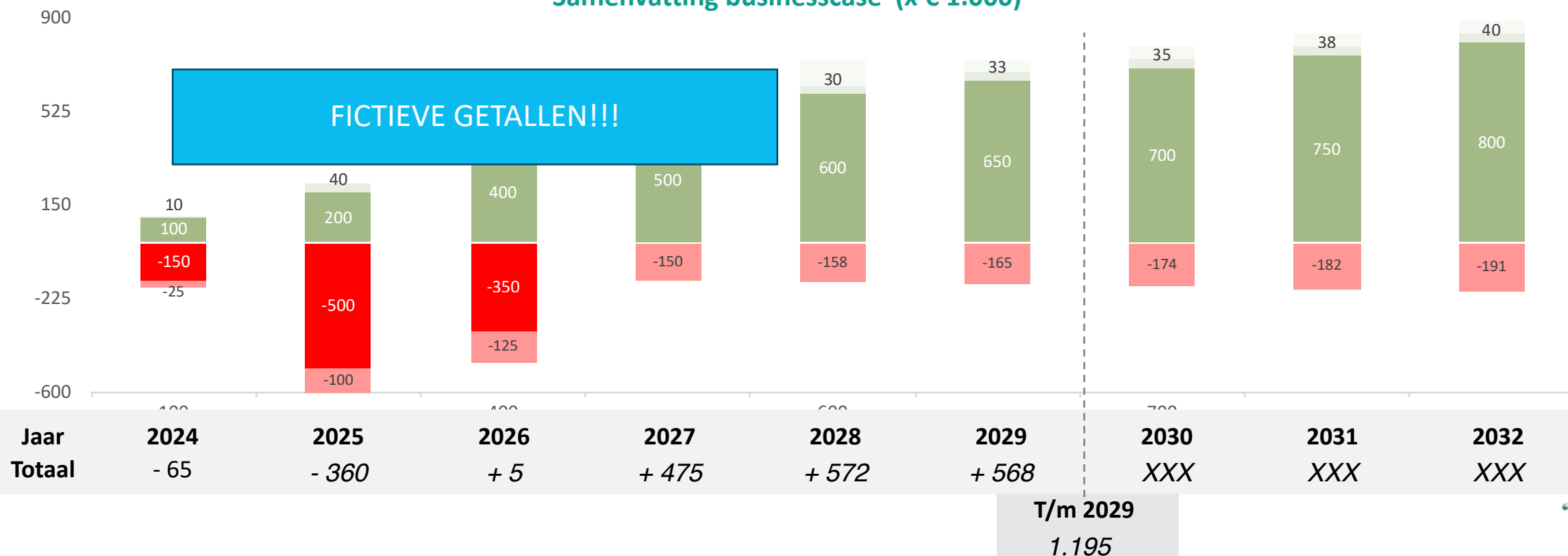
De **impact** kan worden uitgesplitst in **drie categorieën**:

1. Bottom-up gekwantificeerd: De impact die vanuit de impactdrivers, doelgroepen, effecten en inclusie over tijd is bepaald en doorerekend
2. Top-down huidige usecases: Een benadering van de impact die ook met de implementatie van de usecases in dit plan gerealiseerd zal worden, maar die niet bottom-up gekwantificeerd kon worden
3. Top-down nieuwe usecases: Een doorvertaling van nieuwe usecases die na 2026 uitgerold zullen worden in de regio, waarvoor de komende jaren het fundament gelegd zal worden met dit transformatieplan

Ook de **kosten** kunnen in **twee categorieën** worden opgedeeld:

1. Frictiekosten: Deze zien op de uitwerking van processen, implementatie van technologie en adoptie in de regio – hiervoor worden IZA-middelen aangevraagd
2. Directe structurele kosten*: Deze zien op de kosten om het fundament en alles wat hierbij komt kijken in de lucht te houden, te beheren en door te ontwikkelen, zowel qua techniek als qua mensen – deze kosten worden niet meegenomen in de aangevraagde IZA-middelen

Samenvatting businesscase (x € 1.000)





Mogelijke indicatoren voor effectmeting en impactanalyse van beoogde transformaties

Met de realisatie van de usecases en gegevensdiensten onder zowel thema 1, Digitale en (zorg)communicatie met inwoners en patiënten, en professionals onderling, als thema 2, Dossier Inzage en Digitale Overdracht van (Acute) Zorg, ter ondersteuning van de basis op orde, wordt grote impact verwacht.

De verwachte effecten in de regio van het beschikbaar hebben van de juiste informatie, op het juiste moment en op de juiste plek, én het faciliteren van samenwerken in het netwerk, zijn algemeen en over de domeinen.

Algemene effecten	Thema
Hogere kwaliteit zorg	1, 2
Verbeterde ervaring inwoner en professionals	1, 2
Goede regionale samenwerking	1, 2
Gestroomlijnde gegevensuitwisseling	1, 2
Verhoogde effectiviteit	1, 2

VVT	Thema
Reductie fouten in communicatie	2
Verbeterde overdracht	2
Reductie administratieve last	2
Verbeterde kwaliteit acute zorg	2
Verhoogde productiviteit	2

Inwoners	Thema
Hogere kwaliteit zorg	1, 2
Meer regie op eigen zorgproces	1
Één bron van de eigen informatie	1
Minder over/onder behandeling	1,2
Eenvoudig in contact komen met zorgverlener indien nodig	1

Huisartsen	Thema
Reductie fouten in communicatie	1, 2
Verhogen werkplezier	1, 2
Reductie administratieve last	1, 2
Reductie onnodige verwijzingen	1, 2
Verhoogde effectiviteit/passende zorg	1, 2

Ziekenhuizen	Thema
Reductie onnodige verwijzingen	1, 2
Snel en inzichtelijk de gewenste patiëntinformatie	1, 2
Tijdsbesparing consult/JZOJP	1, 2
Gestroomlijnde gegevensuitwisseling	1, 2
Meer tijd voor de patiënt	1, 2

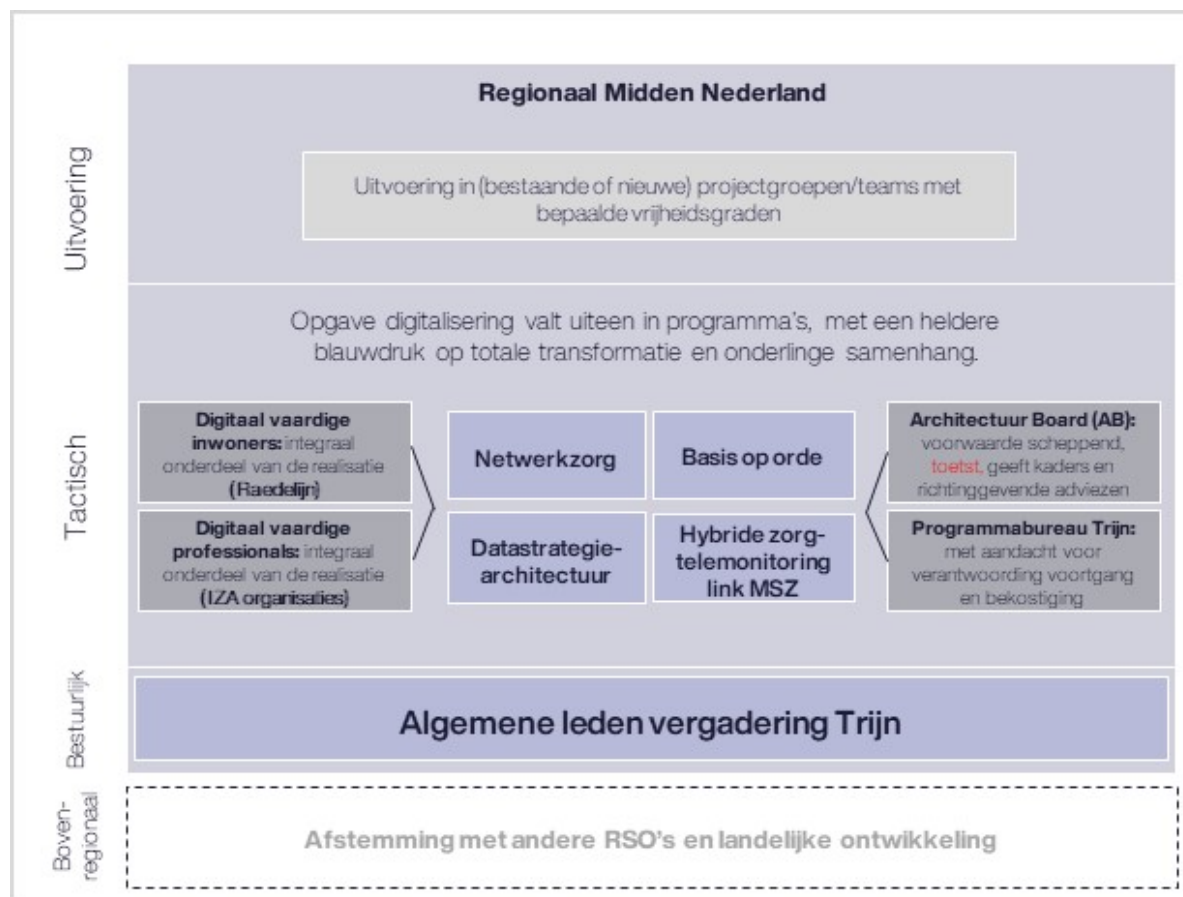


Governance en programmastructuur



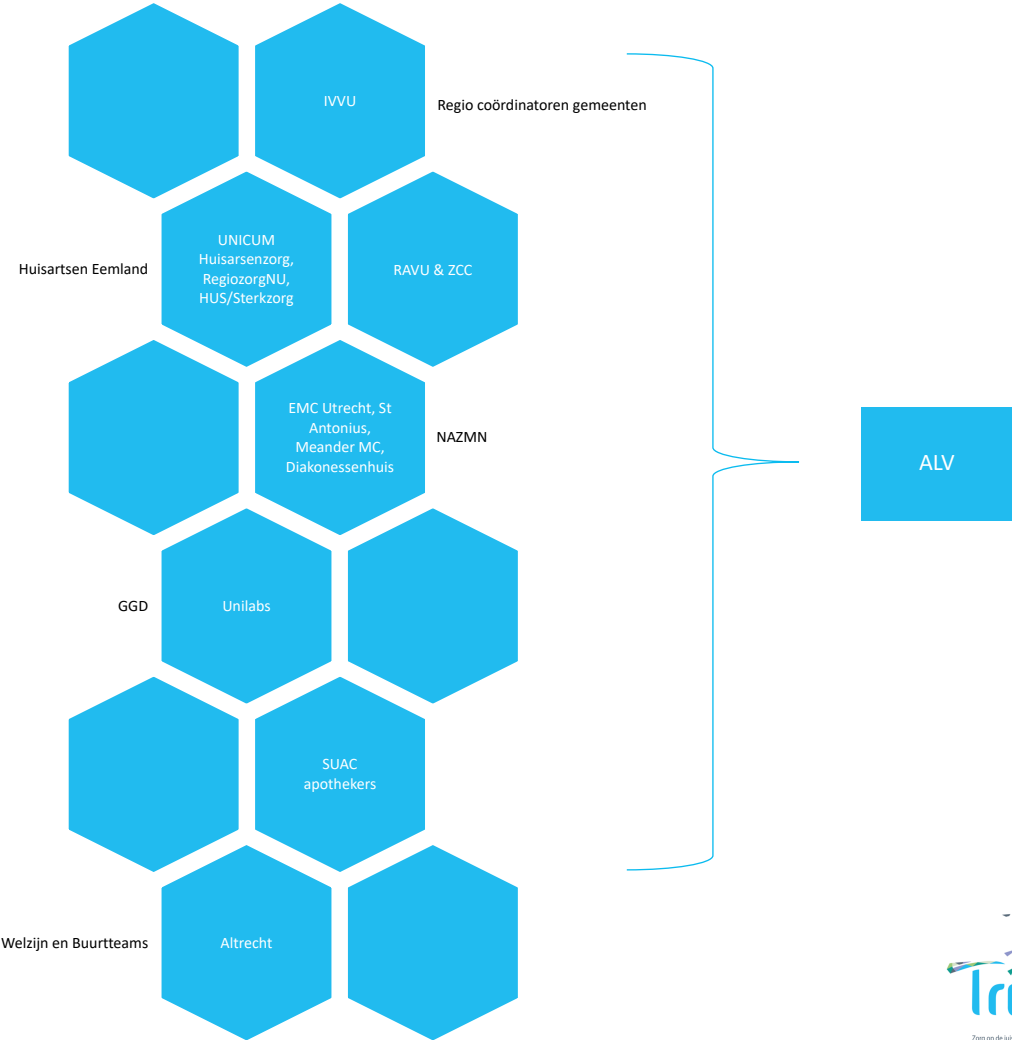
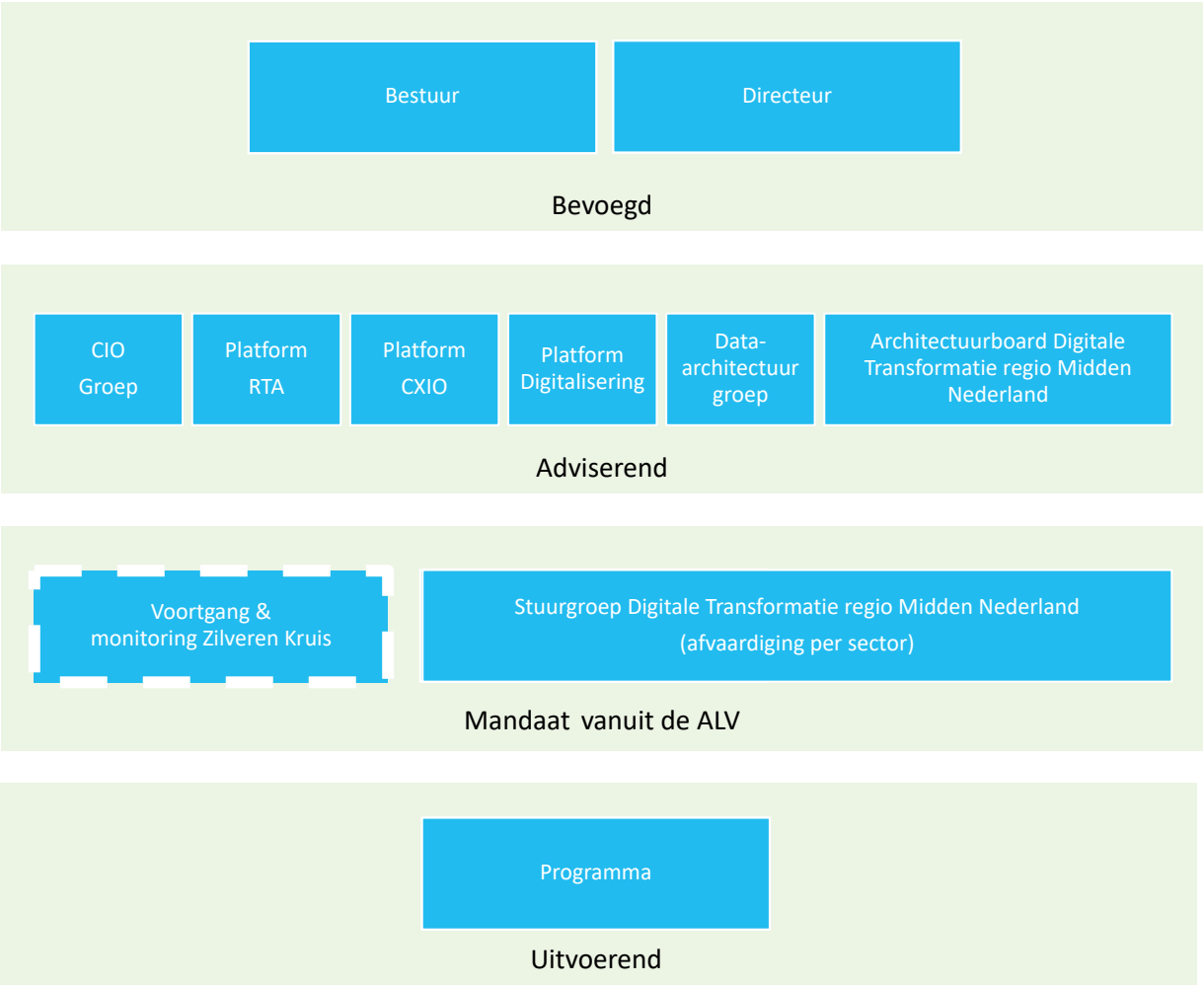
Governance Trijn bij aanvraag transformatie

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van Trijn wordt verbreed naar representatie vanuit de gemeenten, via een regiocoördinator IZA, de GGD, welzijn, de buurtteams en in verbinding met de bewonerstafels. Aansluiting op de gehele IZA transformatie opgave geschiedt via het tactisch en bestuurlijk overleg op regionaal niveau Midden Nederland.



Het programma voor de transformatieopgaven in relatie tot de Governance van Trijn

Vanuit strategisch en tactisch beleid in de regio, vindt de uitvoering van de transformatie opgaven plaats binnen een programma met projectinzet en capaciteit van haar betrokken organisaties, leden en partners.



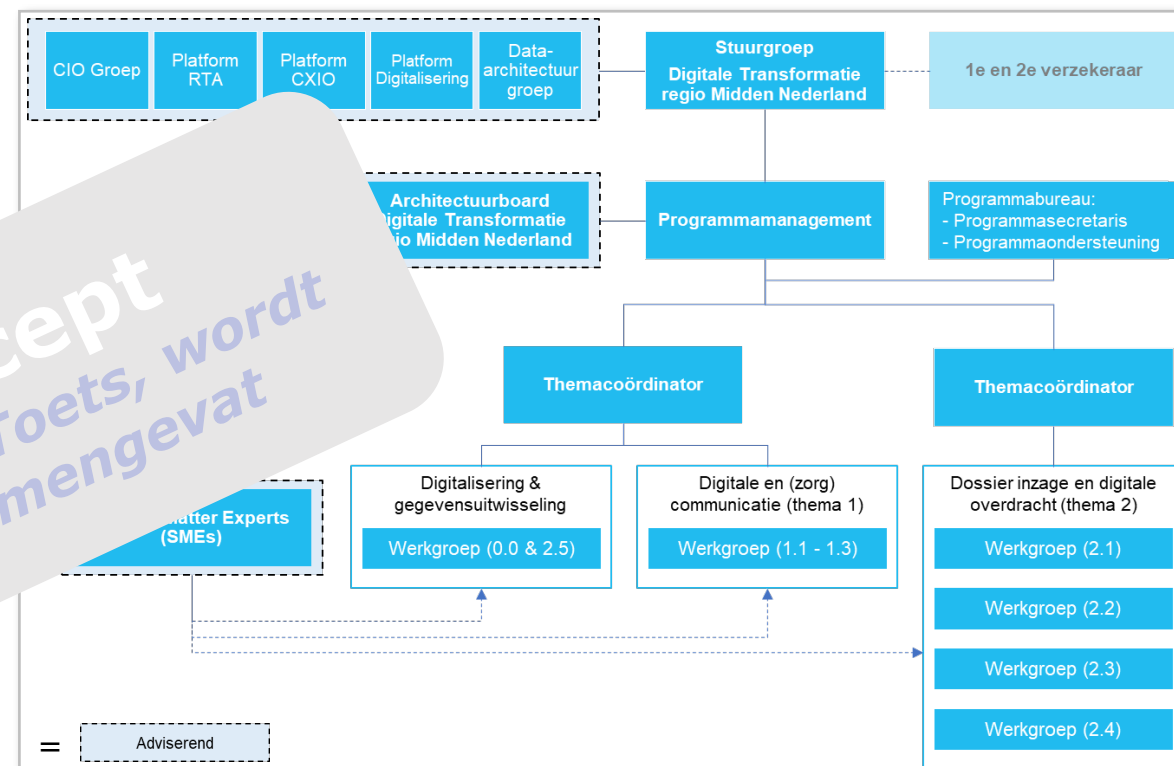


Programmastructuur voor de uitvoering van de IZA Transformatieopgaven

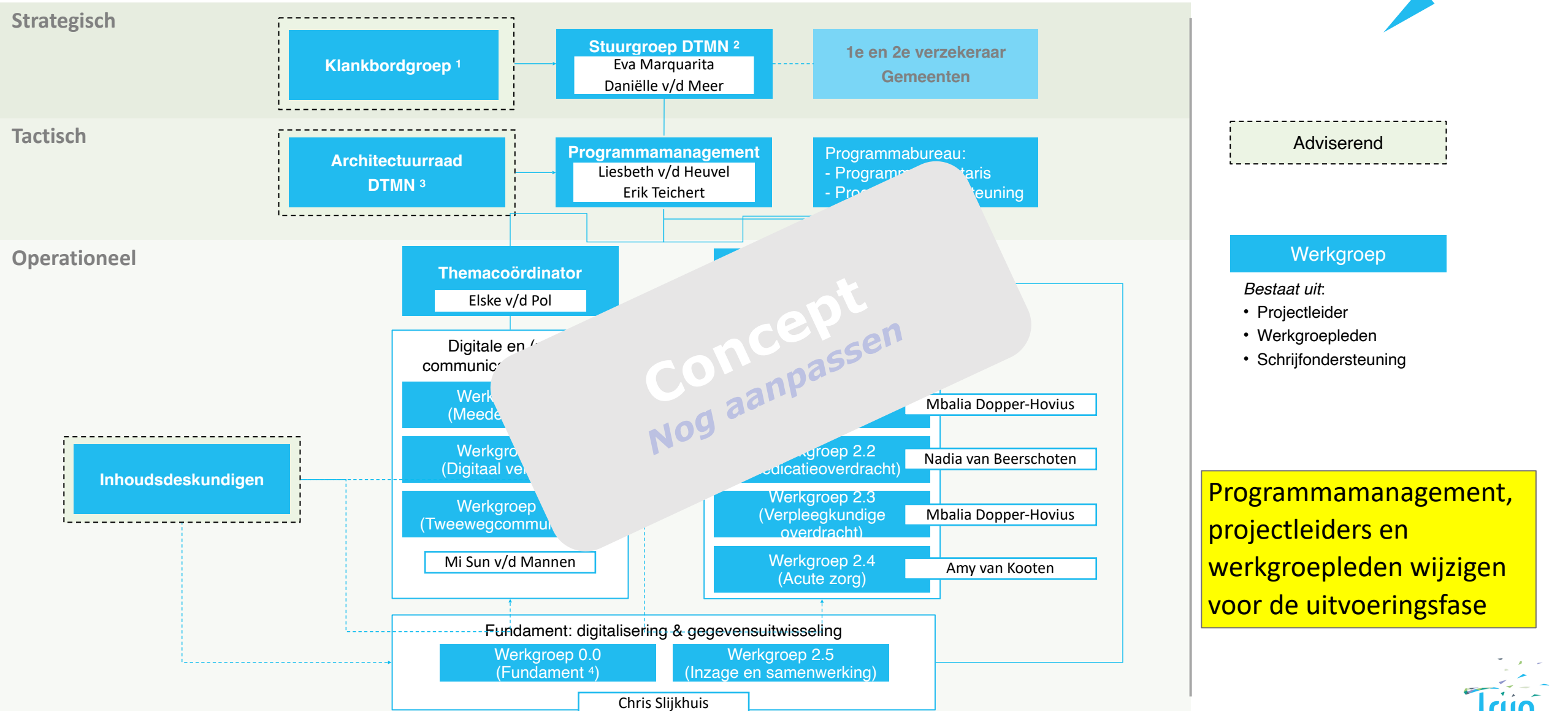
De transformatieopgaven in deze initiële aanvraag snelle toets, zullen na goedkeuring verder worden uitgewerkt in transformatieplannen. Het voorstel voor de programmastructuur op hoofdlijnen is als volgt.

Het programma 'Digitalisering en Databeschikbaarheid als drijvende kracht voor Netwerkzorg in Midden-Nederland' wordt onder regie van RSO Trijn uitgevoerd met haar leden en partners in de regio. Het programma geeft uitvoering aan de ambitie en transformatieopgave van de regio Midden-Nederland als het gaat om domeinoverstijgende digitalisering en gegevensuitwisseling.

O.l.v. een regionale programmamanager, met toezicht van de stuurgroep Digitale Transformatie regio Midden-Nederland en advisering van de Architectuurboard Digitale Transformatie regio Midden-Nederland, wordt vanuit 3 platformen (fundament en 2 use cases) invulling gegeven aan de transformatieopgaven. Daarvoor zijn projecten en werkgroepen onder meer worden ondersteund door het platform. Afhankelijk van de specifieke scope van elk project wordt nader te bepalen in transformatieplannen – of meerdere werkgroepen worden geformeerd met representatie van stakeholders (brede oproep) vanuit de leden van RSO Trijn, het sociaal domein en (andere) partners in de regio.



Programmastructuur IZA transformatieplan

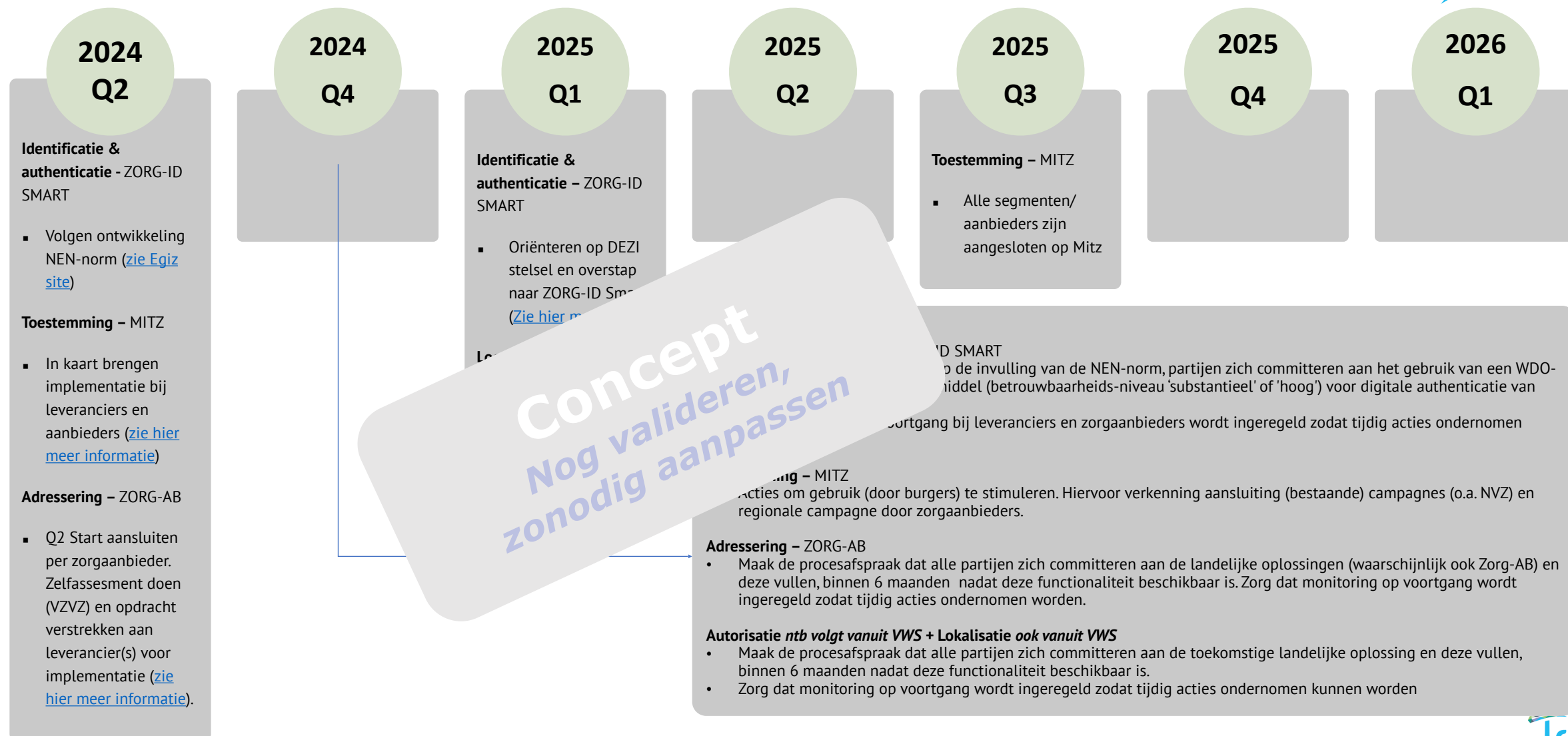




Implementatieplanning en aanpak



Tijdslijnen & afspraken Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen





Tijdslijnen & afspraken inzake Wegiz agenda

2024
Q2

Medicatieoverdracht

Inwerkingtreding AMvB (incl Zibs en FHIR)
Voorschrijven & Ter hand stellen voor: Huisarts naar Apotheek per 01/01/24 en Huisarts naar patient per 01/07/24

eOverdracht

PoC met Dataplatform en Viewer: Inzien/raadplegen eOverdracht data getoetst - voor 3ZH/2VVT/GGZ

Met spoed beschikbaar

Doorstart van Programma 'Met spoed beschikbaar 2.0' voor alle partijen in acute zorgketen ([zie hier](#))

Duwen op uitbreiding van de scope; middels "standaarden" Regionale coördinerol vormgeven samen met ROAZ en procesafspraken maken over transformatie-aanvragen en monitoring

2024
Q4

Medicatieoverdracht

Per zorgaanbieder /regio:

- breng huidige processen in kaart
- volg implementatie bij leveranciers
- sluit aan bij LSP

eOverdracht

evt. Aanmelden bij eOverdracht ICTU voor ondersteuning

Twijn portaal+

Volgen ontwikkelingen rondom update van bestaande oplossingen: Twijn portaal Plus en landelijk XDS ([zie hier](#))

Met spoed beschikbaar

Andere sectoren die hiermee te maken hebben stimuleren dat ook te doen. Actiehouder

2025
Q1

BGZ – VIPP5

Stimuleer aansluiten bij Twijn voor uitwisseling BgZ volgens TA Notified Pull als zorgaanbieder of als regio-organisatie ([zie hier](#))

Medicatieoverdracht

Volg begeleide uitrol Kickstart regio's welke

2025
Q2

BGZ – VIPP5

Publicatie AMvB verwacht voor MSZ (incl. PGO).

UC 2.1 (snelle toets Trijn)
MSZ instellingen
BgZ en con
dig

2025
Q3

BGZ- VIPP5

CDA naar FHIR MSZ leveranciers zijn aan zet

overdracht
AMvB
gevens.

2025
Q4

BGZ – VIPP5

Inwerkingtreding AMvB voor MSZ (incl. PGO) verwacht.

Medicatieoverdracht

Stimuleer stappen ten behoeve van brede uitrol van Medicatieoverdracht in alle segmenten.

2026
Q1

Medicatieoverdracht

UC 2.2 (snelle toets aanvraag Trijn): Voor 2027 in gebruik in alle segmenten/sectoren:

- MP9+Labwaarden+CIO
 - NEN7503+NEN 7542
- UC 2.3 (snelle toets aanvraag Trijn): Voor 2027 in gebruik in MSZ-VVT-(GGZ):
- Dataset eOverdracht verzenden/beschikbaar stellen/opvragen/ontvangen/overnemen

UC 2.4 (snelle toets aanvraag Trijn): in gebruik in MSZ-SEH-HAP-HA-Meldkamer/ZCC/Ambulance:

- Alle verwijzingen+overdrachten digitaal+gestructureerd terugkoppeling
- voldoen aan Informatiestandaard+Kwaliteitsstandaard+NEN 7545

Concept
Nog valideren,
zonodig aanpassen

Overige af

BGZ – VIPP5

- XXX monitort conform tijdslijnen Wegiz, de voortgang en bestending op dit thema per kwartaal bij MSZ zorgaanbieders.

Beeldbeschikbaarheid – Twijn portaal+

- Breng bestaande aansluitingen in de regio in beeld en stimuleer beweging naar landelijke oplossingen in afstemming met de MSZ zorgaanbieders.
- Monitor de voortgang op dit thema per kwartaal.

Met spoed beschikbaar

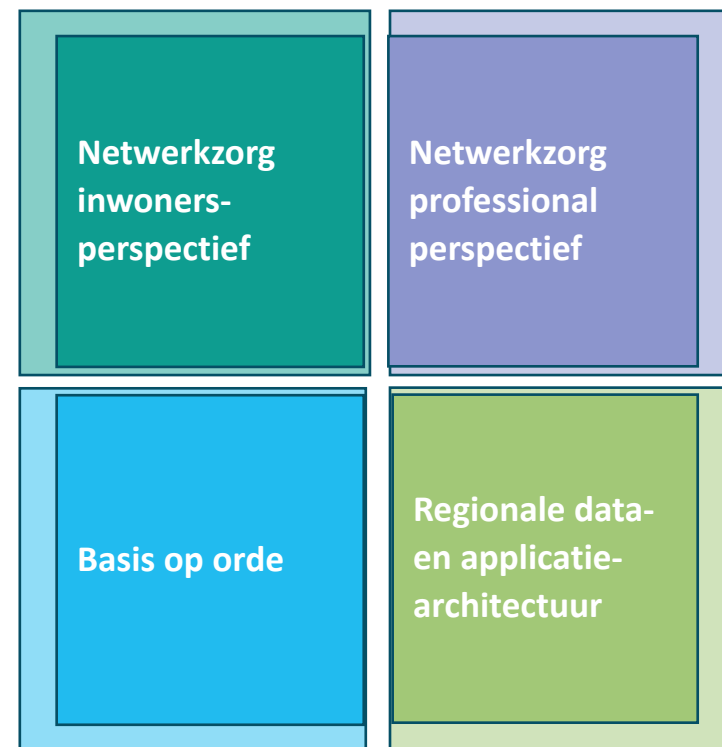
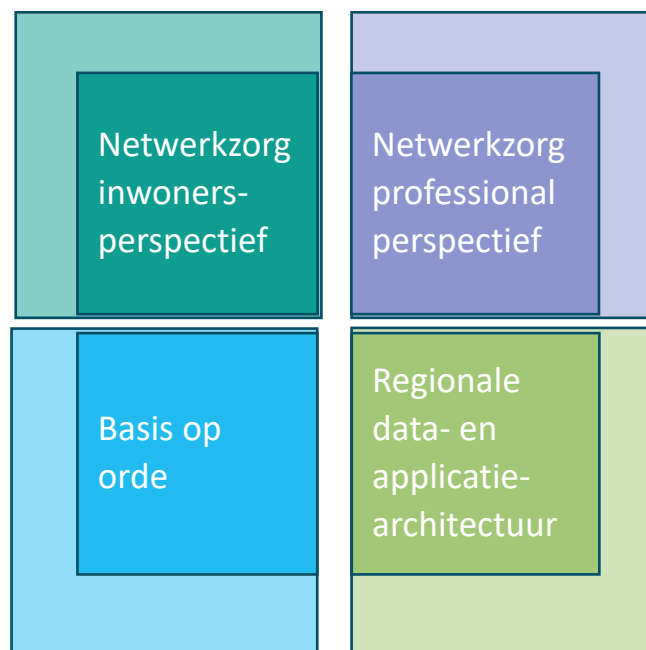
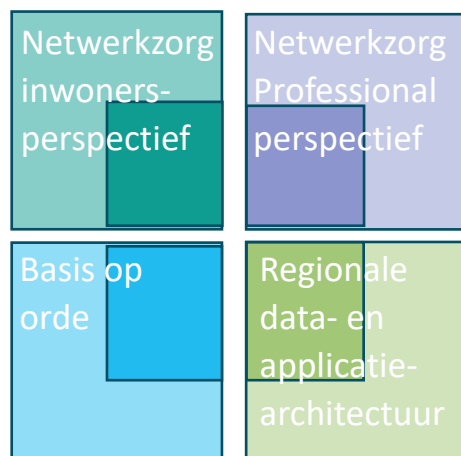
- Politie/BOA's ook hierin meenemen en in RTA's opnemen
- Nagaan welke informatie nodig is, wat er mag (wettelijk) en bij welke wensen dit moet aansluiten.

Plateauplanning voor realisatie

Voor de realisatie van de onderwerpen uit het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling in het IZA regioplan Midden-Nederland, wordt in de uitvoering gewerkt met een plateauplanning.

Dit biedt de mogelijkheid om te leren van de praktijk en zo nodig bij te sturen om aangesloten te blijven op de (regionale) maatschappelijke en/of technologische ontwikkelingen, alsook op het landelijk beleid.

De plateauplanning maakt de enorme uitdaging in de regio behapbaar. De aanvraag geldt voor de IZA looptijd t/m 2026.



Fundament bouwen voor beschikbaar maken van gegevens (Plateau 1 NVS interoperabiliteit)

Fundament bouwen voor beschikbaar maken van gegevens (Plateau 2 NVS Betere ondersteuning van netwerkgorg)

2024

2025

2026

2027

2029

2030



Randvoorwaarden voor succes



Belangrijkste risico's & mitigerende maatregelen (1/2)

Onderwerp		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Project-management	1	Onvoldoende beschikbaarheid van mensen t.b.v. het implementeren van het transformatieplan	Hoog	Hoog	• Escaleren naar en afstemmen met de ALV • Planning vroegtijdig kenbaar maken om tijdig mensen vrij te maken om plannen uit te kunnen voeren (commitment vanuit de organisaties en contractueel vastleggen) • Realisatie van dit transformatieplan prioriteren binnen de zorgorganisaties (bestuurlijke commitment en sturing hierop helpt). Evt. extra personeel aantrekken of inhuren • Voldoende urgentie vanuit de werkvloer werkt ook als stimulans • Er zijn out-of-pocket kosten opgenomen in de business case om in dit geval extern personeel te kunnen inschakelen
Project-management	2	Gebrek aan integraliteit en samenwerking van de usecases, waardoor niet het maximale uit de usecases gehaald kan worden	Hoog	Hoog	• Sessies organiseren met betrokkenen bij alle usecases om dit te borgen en bespreken, met name om de tijdslijnen en technische afhankelijkheden in detail met elkaar door te nemen
Project-management	3	Gebrek aan capaciteit en focus door grote hoeveelheid verschillende projecten in de regio	Hoog	Hoog	• Prioriteren binnen de regio vanuit bestuurders en/of initiatieven onder de paraplu van dit project organiseren
Project-management	4	Vertraging in de uitbetaling van IZA-transformatiegelden door het niet op tijd behalen van mijlpalen o.b.v. de KPI's	Hoog	Hoog	• Regelmatig monitoren en rapporteren op de KPI's zodat eventuele vertragingen tijdig signaleerd kunnen worden • Nauwe afstemming met de zorgverzekeraars over de haalbaarheid van de mijlpalen i.r.t. de realiteit van de transformatie
Governance	5	Het betrekken van een uitgebreide groep belanghebbenden, met name in het vinden van de juiste balans tussen betrokkenheid en de beschikbare tijd van professionals voor dit programma	Hoog	Hoog	• Optie deelname aan werkgroepen óf klankbordgroep
Transformatie expertise	6	Verandermoeheid onder betrokkenen door meerdere projecten/ initiatieven tegelijkertijd of opvolgend (in de regio en/of in organisaties). Dit kan ontstaan door de voortdurende veranderingen.	Hoog	Hoog	• Prioritering en bijsturen door bestuurders noodzakelijk • In het veranderverhaal nadrukkelijk stilstaan bij de ambitie en waarom het belangrijk is om deze ambitie te realiseren. Aansluiten bij de dagelijkse praktijk. • De transformatie borgen vanuit een 'veranderteam' om de verwachte impact te realiseren in de dagelijkse praktijk.



Belangrijkste risico's & mitigerende maatregelen (2/2)

Nog verder aan te vullen

Onderwerp		Risico	Kans	Impact	Mitigerende maatregel
Transformatie expertise	7	Geen goede borging in de regio door hoge mate van externe inzet	Hoog	Hoog	- Mensen vanuit de regio inzetten in werkgroepen. Externen (gefaseerd) laten uitstromen zodra mogelijk - Aanhaken van transformatie-expertise om individuele organisaties te helpen en vinden diverse bijeenkomsten plaats in kader van bewustwording en zorgtransformatie. Hierbij oog houdend voor overdracht en borging van kennis
Transformatie expertise	8	Weerstand tegen (technologische) verandering bij zorgprofessionals en inwoners	Hoog	Hoog	Bewustwording creëren over de noodzaak en kansen om zorg anders te organiseren en te coördineren. Het waarom van de verandering continu blijven communiceren en hierover met de betrokkenen/ betroffene in gesprek gaan
Implementatie fundament	9	Generieke functie Toestemming (MITZ) niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	(Werk-)afspraken maken m.b.t. het vastleggen van toestemming in bronsystemen van zorgaanbieders
Implementatie fundament	10	Generieke functie Identificatie & Autorisatie voor zorgprofessionals niet tijdig beschikbaar	Hoog	Hoog	Tijdelijke workaround ontwikkelen en implementeren (bijv. SSO)
Implementatie fundament	11	Kwaliteit van (gestructureerde) data is te laag door interpretatieverschillen van standaarden bij het inbouwen/ doorontwikkelen van informatiestandaarden/ zorginformatiebouwstenen (ZIBs) door leveranciers terwijl deze wel gekwalificeerd zijn door Nictiz	Hoog	Hoog	- Agenderen bij VWS, Nictiz, e.a. mbv voorbeelden uit de praktijk - Afspraken maken m.b.t. wijze van aggregeren data - Gezamenlijke teststrategie Nictiz, leveranciers en zorgaanbieders formuleren en uitvoeren
Implementatie fundament	12	Onvoldoende (personele) capaciteit bij functioneel beheer en (M)ICT voor technische inrichting/koppeling tussen EPD/ECD en dashboards	Hoog	Hoog	- Prioritering van het Trijn IZA-transformatieplan binnen de zorgorganisaties (met commitment op niveau van RvB/ directie en vanuit CIO's). En tijdelijk extra personeel aantrekken of extern inhuren - Op basis van de opgestelde planning op tijd inventariseren en evalueren of de voorhanden capaciteit voldoende is voor de komende periode – en hierbij de werkvloer betrekken

BIJLAGEN



- [Placeholder]



BIJLAGE A

Detail uitwerking van de usecases